

Buku Ajar
**FARMAKOLOGI
DALAM ASUHAN
KEBIDANAN**

Suci Gustia Saputri
Gita Kostania
Tonasih



BUKU AJAR FARMAKOLOGI DALAM ASUHAN KEBIDANAN

Penulis:

Suci Gustia Saputri, STr.Keb., MPH.

Gita Kostania, S.ST., M.Kes.

Tonasih, SST., M.Kes.



BUKU AJAR FARMAKOLOGI DALAM ASUHAN KEBIDANAN

Penulis: Suci Gustia Saputri, STr.Keb., MPH.

Gita Kostania, S.ST., M.Kes.

Tonasih, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-12-8

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga buku "Farmakologi dalam Asuhan Kebidanan" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun dengan tujuan memberikan panduan yang komprehensif kepada mahasiswa kebidanan serta tenaga kesehatan dalam memahami konsep farmakologi, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip dasar farmakodinamika dan farmakokinetika, serta implementasinya dalam praktik kebidanan yang aman dan efektif.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami tidak hanya konsep teoritis mengenai farmakologi tetapi juga prinsip-prinsip praktis dalam pemberian obat dan cara penanganan efek samping obat (ESO) atau adverse drug reactions (ADRs). Selain itu, buku ini secara khusus menekankan aspek etika dalam pemberian obat dan menguraikan peran penting bidan dalam menjaga tanggung jawab profesionalnya, memastikan keamanan dan efektivitas terapi yang diberikan, serta mengintegrasikan terapi komplementer sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa kebidanan, bidan praktik, dan para profesional kesehatan lainnya dalam meningkatkan kompetensi farmakologis dan kemampuan dalam memberikan asuhan kebidanan secara bertanggung jawab. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga karya ini membawa manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas layanan kebidanan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 KONSEP DASAR DAN PRINSIP FARMAKOLOGI, FARMAKODINAMIKA, DAN FARMAKOKINETIKA..... 1

A. Konsep Dasar dan Prinsip Farmakologi	3
B. Farmakodinamika	6
C. Farmakokinetika	9
D. Latihan Soal	13
E. Rangkuman Materi.....	17
F. Glosarium.....	18
G. Daftar Pustaka.....	21

BAB 2 PRINSIP PEMBERIAN OBAT DAN CARA MENGATASI EFEK SAMPING OBAT 23

A. Prinsip Pemberian Obat	26
B. Cara Mengatasi Efek Samping (ESO) / Adverse Drug Reactions (ADRs)	37
C. Latihan	48
D. Rangkuman Materi	52
E. Glosarium.....	54
F. Daftar Pustaka.....	55

BAB 3 ETIKA PEMBERIAN OBAT DAN TERAPI	
KOMPLEMENTER DALAM ASUHAN KEBIDANAN.....	59
A. Etika dalam Pemberian Obat.....	61
B. Tanggung Jawab Profesional Bidan.....	65
C. Keamanan dan Efektivitas Obat	66
D. Terapi Komplementer dalam Asuhan Kebidanan ...	69
E. Integrasi Terapi Komplementer dan Konvensional.....	73
F. Latihan soal	76
G. Rangkuman Materi.....	81
H. Glosarium	83
I. Daftar Pustaka.....	86
PROFIL PENULIS	89

BAB 1

KONSEP DASAR DAN PRINSIP FARMAKOLOGI, FARMAKODINAMIKA, DAN FARMAKOKINETIKA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip dasar farmakologi dalam asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek farmakodinamika dan farmakokinetika secara komprehensif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar farmakologi, farmakodinamika, dan farmakokinetika serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam asuhan kebidanan untuk memastikan keselamatan dan efektivitas terapi farmakologi pada ibu dan bayi.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar dan prinsip farmakologi.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme kerja obat (farmakodinamika).
- Menguraikan proses farmakokinetika obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.

- Mengintegrasikan pemahaman farmakologi dalam pengelolaan terapi pada kasus-kasus kebidanan.

Pendahuluan

Farmakologi merupakan ilmu esensial dalam asuhan kebidanan yang memungkinkan bidan memberikan perawatan yang aman, tepat, dan efektif kepada ibu dan bayi. Dalam praktik kebidanan, pemahaman terhadap prinsip farmakologi, farmakodinamika, dan farmakokinetika menjadi dasar untuk pengambilan keputusan klinis yang rasional dan berbasis bukti. Penguasaan konsep ini sangat penting untuk memastikan penggunaan obat yang efektif dan menghindari risiko yang tidak diinginkan selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

A. Konsep Dasar dan Prinsip Farmakologi

Farmakologi merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada studi tentang bagaimana obat-obatan berinteraksi dengan sistem biologis, terutama dalam konteks pengaruh terapeutiknya terhadap manusia. Secara khusus, farmakologi membahas secara mendalam mekanisme kerja obat, proses interaksi obat dalam tubuh, penggunaan klinis yang tepat, dosis optimal, serta efek samping dan kontraindikasi penggunaannya. Bidang ini tidak hanya sebatas mengetahui efek terapeutik suatu obat, tetapi juga bagaimana efek tersebut tercipta, serta potensi risiko dan manfaat yang diperoleh pasien dari penggunaan obat tersebut.

Dalam praktik kebidanan, penerapan farmakologi memiliki dimensi yang khusus dan kompleks. Bidan harus memahami secara mendalam konsep dasar farmakologi untuk menjamin keamanan ibu hamil, ibu menyusui, serta janin yang sedang berkembang. Hal ini penting karena penggunaan obat-obatan selama masa kehamilan dan menyusui memerlukan pertimbangan ekstra mengenai efek farmakologis yang mungkin muncul terhadap dua individu sekaligus—ibu dan janin atau bayi. Setiap obat yang diberikan tidak hanya mempengaruhi ibu secara langsung, tetapi juga berpotensi mempengaruhi perkembangan janin, menembus plasenta, atau ekskresi melalui ASI yang berdampak terhadap bayi yang disusui.

Prinsip utama dalam farmakologi kebidanan adalah memastikan obat yang digunakan memiliki efikasi yang jelas, artinya secara efektif mengatasi keluhan atau kondisi klinis yang dialami oleh ibu tanpa memberikan risiko signifikan terhadap janin atau bayi. Bidan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan selalu mengacu pada bukti ilmiah terbaru (evidence-based practice). Ini melibatkan pengetahuan tentang bagaimana obat-obatan tertentu diproses dalam tubuh wanita hamil atau menyusui, meliputi absorpsi (penyerapan obat ke dalam tubuh), distribusi (penyebaran obat dalam tubuh), metabolisme (proses biotransformasi obat oleh tubuh), dan eliminasi (proses pengeluaran obat dari tubuh). Semua proses ini secara kolektif dikenal sebagai farmakokinetika.

Selain farmakokinetika, farmakodinamika juga menjadi konsep penting dalam kebidanan. Farmakodinamika menjelaskan bagaimana obat bekerja dalam tubuh, termasuk mekanisme aksinya di tingkat molekuler dan fisiologis. Pemahaman tentang farmakodinamika memungkinkan bidan untuk memprediksi respons tubuh terhadap obat yang diberikan, menyesuaikan dosis secara tepat, serta mengantisipasi potensi efek samping yang mungkin timbul.

Misalnya, ketika memberikan analgesik kepada ibu dalam masa persalinan, bidan harus memahami dengan baik mekanisme analgesik tersebut dalam meredakan nyeri, dosis optimal yang aman bagi ibu dan bayi, serta potensi efek samping seperti depresi pernapasan atau penurunan kesadaran. Di sisi lain, penggunaan obat-obatan untuk

mengatasi komplikasi seperti perdarahan postpartum memerlukan pemahaman tentang mekanisme kontraksi uterus yang dipicu oleh obat tertentu, serta risiko efek sampingnya seperti hipertensi atau gangguan hemodinamik.

Keselamatan penggunaan obat dalam kebidanan juga mencakup pertimbangan khusus seperti kategori keamanan obat pada kehamilan. Misalnya, obat yang termasuk kategori A memiliki bukti keamanan yang kuat untuk digunakan selama kehamilan, sementara obat kategori D dan X memiliki risiko tinggi menyebabkan malformasi atau gangguan perkembangan janin, sehingga penggunaannya harus benar-benar dipertimbangkan secara ketat dan cermat oleh tenaga kesehatan.

Bidan juga dituntut memahami efek samping yang mungkin timbul selama masa menyusui, karena beberapa obat bisa masuk ke dalam ASI dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan pada bayi, seperti gangguan tidur, diare, atau bahkan risiko toksisitas yang lebih serius.

Secara umum, prinsip farmakologi dalam kebidanan menekankan pendekatan yang rasional dalam pemberian obat: tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu pemberian, tepat cara pemberian, serta tepat evaluasi efeknya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara ketat, bidan mampu memberikan asuhan kebidanan yang optimal, menjaga keselamatan ibu dan bayi, serta memastikan terapi obat yang digunakan efektif dalam menangani kondisi klinis yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.

B. Farmakodinamika

Farmakodinamika merupakan cabang dari ilmu farmakologi yang secara khusus mempelajari tentang efek-efek yang ditimbulkan oleh suatu obat terhadap tubuh. Dalam pengertian yang lebih luas, farmakodinamika menjelaskan bagaimana obat bekerja di dalam tubuh setelah berinteraksi dengan berbagai molekul biologis, terutama melalui reseptor, enzim, saluran ion, ataupun transporter tertentu. Pemahaman mendalam tentang farmakodinamika sangat penting dalam praktik kebidanan, karena efek obat yang diberikan kepada ibu hamil atau menyusui akan mempengaruhi tidak hanya ibu, tetapi juga janin atau bayi.

1. Reseptor dan Efek Obat

Konsep reseptor menjadi sangat penting dalam farmakodinamika karena hampir semua obat memberikan efek dengan cara berikatan dengan reseptor spesifik di dalam tubuh. Reseptor adalah protein khusus di permukaan atau di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat spesifik bagi obat untuk berikatan. Ketika obat berikatan dengan reseptor yang tepat, maka akan terjadi perubahan fungsi fisiologis atau biokimia tertentu dalam tubuh, yang menghasilkan efek terapeutik.

Misalnya, obat oksitosin yang sering digunakan dalam praktik kebidanan untuk merangsang kontraksi uterus, bekerja dengan cara berikatan secara spesifik pada reseptor oksitosin di otot polos uterus. Interaksi ini memicu serangkaian reaksi biokimia yang mengaktifkan otot uterus untuk berkontraksi secara lebih kuat dan

teratur, yang penting dalam penatalaksanaan persalinan maupun pencegahan perdarahan postpartum.

Efek obat pada reseptor ini juga dapat bervariasi. Sebuah obat dapat berfungsi sebagai agonis (mengaktifkan reseptor), antagonis (menghambat reseptor), atau agonis parsial (menghasilkan efek sebagian). Penting bagi bidan memahami perbedaan ini, karena jenis interaksi ini akan menentukan efek klinis yang dihasilkan.

2. Efikasi dan Potensi Obat

Efikasi dan potensi adalah dua konsep utama yang harus dimengerti secara mendalam dalam farmakodinamika. Efikasi merujuk pada kapasitas maksimal suatu obat dalam menghasilkan efek klinis yang diinginkan, sementara potensi berkaitan dengan konsentrasi atau dosis obat yang diperlukan untuk mencapai efek terapeutik tersebut.

Efikasi menggambarkan seberapa besar efek maksimal yang bisa dicapai oleh obat tertentu tanpa memperhitungkan dosisnya. Misalnya, dalam penggunaan analgesik selama persalinan, morfin memiliki efikasi lebih tinggi dibandingkan dengan parasetamol, karena efek analgesia maksimalnya jauh lebih kuat. Dengan demikian, jika pasien mengalami nyeri hebat, pemilihan obat akan mempertimbangkan efikasi sebagai prioritas utama.

Sementara itu, potensi menunjukkan seberapa kecil dosis obat yang diperlukan untuk menghasilkan efek

tertentu. Obat dengan potensi tinggi akan menghasilkan efek yang signifikan meski diberikan dalam dosis kecil. Contohnya adalah misoprostol dalam kebidanan, yang memiliki potensi tinggi dalam merangsang kontraksi uterus walaupun dalam dosis mikrogram yang sangat kecil.

Memahami kedua aspek ini penting bagi bidan untuk menentukan jenis obat yang paling tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien. Penggunaan dosis yang tepat tidak hanya menghasilkan efek terapi optimal tetapi juga mengurangi risiko efek samping.

3. Efek Samping dan Toksisitas

Efek samping adalah reaksi yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi bersamaan dengan efek terapi yang diinginkan ketika obat diberikan dalam dosis yang dianjurkan. Toksisitas, di sisi lain, adalah efek negatif yang muncul ketika kadar obat dalam tubuh mencapai batas yang berbahaya, biasanya akibat dosis berlebihan atau interaksi obat.

Pemahaman efek samping menjadi sangat penting dalam konteks kebidanan karena adanya dua kehidupan yang terlibat langsung, yaitu ibu dan janin atau bayi yang disusui. Efek samping pada ibu hamil dapat memiliki dampak tambahan pada perkembangan janin, seperti malformasi kongenital, gangguan pertumbuhan, atau bahkan kematian janin.

Sebagai contoh, obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) memiliki risiko tinggi efek samping seperti

penutupan dini duktus arteriosus pada janin jika digunakan pada trimester ketiga kehamilan, yang dapat menyebabkan komplikasi serius setelah lahir. Dengan memahami efek samping ini, bidan akan memilih alternatif terapi lain yang lebih aman selama masa kehamilan.

Selain efek samping, risiko toksisitas juga harus dipertimbangkan secara cermat oleh bidan. Misalnya, penggunaan magnesium sulfat untuk mengatasi preeklamsia harus dipantau secara ketat karena dosis yang berlebihan dapat menyebabkan toksisitas serius seperti depresi pernapasan, gangguan refleks tendon, hingga gagal jantung pada ibu.

C. Farmakokinetika

Farmakokinetika merupakan bagian dari ilmu farmakologi yang secara khusus mempelajari bagaimana tubuh memperlakukan obat setelah masuk ke dalam tubuh manusia. Secara mendetail, farmakokinetika menjelaskan perjalanan atau nasib obat di dalam tubuh sejak awal pemberian hingga dikeluarkan dari tubuh. Pemahaman mengenai farmakokinetika dalam kebidanan sangat krusial karena kondisi fisiologis ibu selama kehamilan maupun menyusui secara signifikan dapat mempengaruhi proses ini. Perubahan fisiologis tersebut menuntut adanya penyesuaian dosis, frekuensi, dan cara pemberian obat agar aman dan efektif bagi ibu serta janin atau bayi.

Farmakokinetika mencakup empat proses utama yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang semuanya memiliki karakteristik unik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kehamilan atau laktasi.

1. Absorpsi

Absorpsi adalah proses awal yang terjadi segera setelah obat diberikan, yakni masuknya obat dari tempat pemberian menuju aliran darah. Proses ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara pemberian obat, sifat fisikokimia obat, luas permukaan absorpsi, serta kondisi fisiologis pasien.

Dalam kebidanan, kondisi kehamilan menyebabkan berbagai perubahan fisiologis seperti peningkatan volume darah, perubahan motilitas gastrointestinal, serta peningkatan aliran darah ke berbagai jaringan termasuk mukosa lambung dan usus. Misalnya, akibat perubahan hormonal selama kehamilan, motilitas saluran cerna menjadi lebih lambat sehingga waktu tinggal obat di saluran cerna bertambah, hal ini dapat memperlambat absorpsi obat yang diberikan secara oral. Sebaliknya, peningkatan aliran darah pada kulit dan otot selama kehamilan bisa mempercepat absorpsi obat yang diberikan melalui injeksi intramuskular atau subkutan.

Dengan memahami efek kondisi fisiologis ini, bidan perlu mempertimbangkan cara pemberian dan dosis yang paling tepat agar obat terserap optimal dan mencapai efek terapeutik yang diinginkan tanpa risiko overdosis atau efek samping yang tidak diinginkan.

2. Distribusi

Distribusi adalah proses penyebaran obat dari aliran darah ke berbagai jaringan tubuh untuk mencapai tempat aksinya. Distribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aliran darah ke jaringan tersebut, permeabilitas jaringan terhadap obat, dan derajat ikatan obat dengan protein plasma darah.

Pada kehamilan, perubahan fisiologis seperti peningkatan volume darah total dan penurunan konsentrasi albumin (protein plasma yang utama) dapat secara signifikan mempengaruhi distribusi obat. Karena banyak obat terikat kuat dengan protein plasma, penurunan kadar albumin selama kehamilan menyebabkan meningkatnya fraksi bebas obat dalam darah. Fraksi bebas ini merupakan bentuk aktif obat yang akan berinteraksi dengan reseptor, sehingga jika tidak diperhitungkan dengan baik, dapat menimbulkan efek terapeutik berlebih (overdosis relatif) atau efek samping yang tidak diinginkan.

Selain itu, adanya plasenta sebagai organ baru selama kehamilan juga memungkinkan obat untuk melintasi plasenta sehingga berpotensi mempengaruhi janin. Pengetahuan ini mendorong bidan untuk selalu mempertimbangkan sejauh mana obat tertentu bisa mempengaruhi janin saat memilih terapi yang aman.

3. Metabolisme

Metabolisme atau biotransformasi merupakan proses transformasi kimia yang dialami obat di dalam

tubuh, terutama di hati. Tujuan utama metabolisme obat adalah mengubah molekul obat menjadi bentuk metabolit yang lebih polar (larut air) sehingga lebih mudah diekskresikan melalui ginjal atau jalur ekskresi lain seperti empedu.

Selama kehamilan, fungsi hati ibu bisa mengalami perubahan signifikan. Aktivitas enzim hati tertentu mungkin meningkat, sedangkan aktivitas enzim lain mungkin menurun. Perubahan ini dapat menyebabkan perbedaan kecepatan metabolisme obat sehingga konsentrasi obat aktif dalam darah bisa meningkat atau berkurang dari biasanya. Contohnya, perubahan aktivitas enzim sitokrom P450 yang bertanggung jawab atas metabolisme banyak obat, seperti antibiotik atau analgesik, mengharuskan bidan menyesuaikan dosis obat dengan cermat agar tetap aman dan efektif.

4. Ekskresi

Ekskresi adalah tahap terakhir dari farmakokinetika, yaitu proses eliminasi atau pengeluaran obat dari tubuh setelah metabolisme. Ginjal merupakan organ utama dalam proses ini, tetapi empedu, paru-paru, dan susu ibu juga berperan penting dalam beberapa situasi khusus.

Selama kehamilannya, ibu mengalami peningkatan aliran darah ke ginjal dan peningkatan filtrasi glomerulus, yang menyebabkan obat dan metabolitnya diekskresikan lebih cepat melalui ginjal. Hal ini bisa menyebabkan efek obat menjadi lebih pendek dari yang diharapkan. Sebaliknya, perubahan fungsi ginjal yang abnormal

(misalnya pada ibu dengan preeklamsia) dapat menyebabkan akumulasi obat dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko toksisitas.

Selain ginjal, ekskresi obat melalui susu ibu (ASI) juga sangat penting diperhatikan selama masa menyusui. Beberapa obat dapat masuk ke dalam ASI, yang berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan bagi bayi yang menyusui. Pemilihan obat yang aman selama menyusui atau penyesuaian waktu pemberian obat (misalnya segera setelah menyusui untuk mengurangi kadar dalam ASI saat bayi menyusu kembali) sangat penting diperhatikan oleh bidan dalam praktik kebidanan sehari-hari.

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang wanita hamil usia 30 tahun, G2P1A0 usia kehamilan 32 minggu datang ke klinik kebidanan dengan keluhan sakit kepala hebat dan mual. Pemeriksaan tekanan darah menunjukkan 160/110 mmHg. Dokter memberikan Magnesium Sulfat (MgSO_4) sebagai terapi untuk mencegah kejang.

Apa prinsip farmakologi yang paling penting diperhatikan bidan terkait pemberian obat tersebut?

- A. Efikasi analgesiknya
- B. Potensi dalam dosis kecil
- C. Mekanisme kerja agonis reseptor
- D. Risiko toksisitas dan efek samping

E. Efektivitas sebagai antibiotik

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Magnesium sulfat digunakan pada kasus preeklamsia berat untuk mencegah kejang, namun memiliki risiko toksisitas tinggi seperti depresi pernapasan, gangguan refleks tendon, hingga gagal jantung. Bidan harus memperhatikan risiko toksisitas dengan pemantauan ketat tanda vital ibu dan refleks tendon dalam pemberian MgSO_4 .

Soal 2

Seorang ibu menyusui datang ke klinik kebidanan dengan keluhan nyeri pasca operasi sesar. Bidan mempertimbangkan analgesik yang aman. Salah satu pertimbangannya adalah risiko ekskresi ke dalam ASI.

Konsep farmakokinetika yang paling relevan dalam pemilihan obat ini adalah:

- A. Metabolisme obat oleh hati
- B. Distribusi obat melalui plasenta
- C. Ekskresi obat melalui ASI
- D. Absorpsi melalui saluran cerna
- E. Distribusi melalui ikatan protein plasma

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Ekskresi obat melalui ASI sangat penting diperhatikan dalam kebidanan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan pada bayi yang sedang disusui.

Soal 3

Seorang ibu usia 28 tahun, G1P0 usia kehamilan 39 minggu mengalami persalinan macet akibat lemahnya kontraksi uterus. Dokter memutuskan memberikan oksitosin untuk memperkuat kontraksi.

Apa mekanisme farmakodinamika oksitosin dalam kasus ini?

- A. Menghambat reseptor adrenergik di uterus
- B. Mengaktifkan reseptor spesifik oksitosin di otot uterus
- C. Merangsang produksi prostaglandin secara langsung
- D. Menghambat saluran kalsium uterus
- E. Mengurangi sensitivitas reseptor progesteron uterus

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Oksitosin bekerja dengan berikatan spesifik pada reseptor oksitosin di otot polos uterus, menyebabkan kontraksi uterus yang lebih kuat dan teratur, sehingga efektif dalam manajemen persalinan.

Soal 4

Seorang wanita hamil trimester ketiga datang dengan keluhan nyeri hebat akibat cedera kaki. Bidan mengetahui bahwa obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) tidak boleh diberikan pada trimester ketiga.

Alasan farmakologi yang tepat mengapa NSAID dikontraindikasikan adalah:

- A. Menghambat absorpsi nutrisi janin
- B. Menyebabkan hiperaktivitas janin
- C. Risiko penutupan dini duktus arteriosus janin

- D. Meningkatkan absorpsi melalui plasenta
- E. Mengurangi metabolisme hati janin

Kunci Jawaban: C

Rasional:

NSAID pada trimester ketiga berisiko tinggi menyebabkan penutupan dini duktus arteriosus pada janin, yang dapat menyebabkan komplikasi serius setelah lahir, sehingga kontraindikasi mutlak.

Soal 5

Seorang ibu hamil usia 24 minggu mengalami infeksi saluran kemih. Dokter memberikan antibiotik yang memiliki kategori keamanan "B" dalam kehamilan.

Apa prinsip farmakologi yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan antibiotik kategori B ini pada kehamilan?

- A. Obat benar-benar aman tanpa risiko apa pun
- B. Tidak boleh diberikan karena menyebabkan malformasi janin
- C. Obat memiliki bukti keamanan cukup, namun tetap harus hati-hati penggunaannya
- D. Harus diberikan dosis besar agar efektif
- E. Hanya efektif jika diberikan intramuskular

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Obat kategori B memiliki bukti keamanan yang baik, namun penggunaannya tetap memerlukan prinsip kehati-hatian karena tidak ada obat yang benar-benar bebas risiko

sepenuhnya selama masa kehamilannya. Bidan harus terus memantau kondisi ibu dan janin secara rutin.

E. Rangkuman Materi

Farmakologi merupakan ilmu penting dalam kebidanan yang memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh ibu hamil, ibu menyusui, dan janin atau bayi yang disusui. Pemahaman tentang konsep dasar dan prinsip farmakologi membantu bidan dalam memilih terapi obat yang efektif, aman, dan rasional dengan memperhatikan efikasi, potensi, serta risiko efek samping dan toksisitas yang mungkin muncul. Farmakodinamika memberikan wawasan tentang mekanisme kerja obat melalui interaksi dengan reseptor spesifik, sehingga bidan dapat memilih obat berdasarkan efek terapi maksimal yang diinginkan dengan dosis yang tepat. Di sisi lain, farmakokinetika menjelaskan bagaimana tubuh ibu memperlakukan obat melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fisiologis selama kehamilan dan menyusui.

Oleh karena itu, bidan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam praktiknya, selalu mempertimbangkan bukti ilmiah terbaru serta memahami perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu selama masa kehamilan dan menyusui. Dengan demikian, penerapan farmakologi secara tepat akan meningkatkan efektivitas pengobatan, mengurangi risiko komplikasi, serta

memastikan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya selama masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menyusui.

F. Glosarium

Farmakologi

Ilmu kesehatan yang mempelajari interaksi antara obat-obatan dengan sistem biologis tubuh manusia, mencakup mekanisme kerja obat, penggunaan klinis yang tepat, dosis optimal, efek samping, kontraindikasi, serta potensi risiko dan manfaat dari penggunaannya.

Farmakologi Kebidanan

Cabang khusus dari ilmu farmakologi yang membahas penggunaan obat-obatan dalam konteks kehamilan, persalinan, nifas, dan masa menyusui. Fokus utamanya adalah keamanan dan efikasi terapi obat terhadap ibu, janin, dan bayi yang disusui.

Efikasi Obat

Kemampuan maksimal sebuah obat untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Dalam kebidanan, efikasi menentukan pilihan terapi untuk kondisi klinis tertentu, seperti analgesia persalinan atau kontraksi uterus.

Potensi Obat

Ukuran konsentrasi atau dosis minimal yang diperlukan untuk mencapai efek terapi tertentu. Obat dengan potensi tinggi mampu memberikan efek signifikan dengan dosis yang relatif kecil.

Farmakokinetika

Cabang farmakologi yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh, dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi. Kondisi kehamilan sangat mempengaruhi proses farmakokinetika, sehingga penting diperhatikan dalam penyesuaian dosis dan cara pemberian obat.

Absorpsi Obat

Proses awal masuknya obat dari tempat pemberian (oral, injeksi, topikal) menuju aliran darah. Dalam kehamilan, absorpsi dipengaruhi oleh perubahan fisiologis seperti perlambatan motilitas gastrointestinal atau peningkatan aliran darah ke jaringan tertentu.

Distribusi Obat

Penyebaran obat dari aliran darah ke jaringan tubuh untuk mencapai tempat aksi terapeutiknya. Pada wanita hamil, distribusi obat sangat dipengaruhi oleh volume darah yang meningkat dan penurunan kadar protein plasma, sehingga meningkatkan fraksi obat aktif dalam tubuh.

Metabolisme Obat

Proses transformasi kimiawi obat dalam tubuh, terutama terjadi di hati, yang mengubah obat menjadi metabolit yang lebih mudah dikeluarkan melalui ginjal atau empedu. Aktivitas metabolisme obat selama kehamilan dapat meningkat atau menurun tergantung jenis enzim hati yang terlibat.

Ekskresi Obat

Proses eliminasi obat atau metabolitnya dari tubuh. Ginjal merupakan organ utama ekskresi, tetapi proses ini juga bisa terjadi melalui empedu, paru-paru, atau susu ibu. Ekskresi

obat melalui ASI sangat penting dipertimbangkan dalam masa menyusui karena dampaknya pada bayi.

Farmakodinamika

Cabang ilmu farmakologi yang mempelajari mekanisme kerja dan efek biologis obat pada tubuh manusia, terutama melalui interaksi dengan reseptor spesifik, enzim, atau protein lainnya dalam tubuh. Pemahaman farmakodinamika membantu menentukan efektivitas, keamanan, dan risiko penggunaan obat dalam kebidanan.

Reseptor Obat

Protein spesifik pada permukaan atau di dalam sel yang menjadi tempat berikatan obat sehingga menghasilkan perubahan fisiologis atau biokimia yang diinginkan. Contohnya adalah reseptor oksitosin pada otot polos uterus.

Agonis

Obat yang bekerja dengan cara mengaktifkan reseptor tertentu untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Contoh: Oksitosin sebagai agonis reseptor oksitosin.

Antagonis

Obat yang bekerja dengan cara menghambat atau memblokir reseptor, sehingga mencegah efek obat lain atau zat alami dalam tubuh. Antagonis biasanya digunakan untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan atau overdosis obat tertentu.

Efek Samping

Reaksi tidak diinginkan yang timbul ketika obat diberikan dalam dosis terapi. Efek samping dalam kebidanan sangat

diperhatikan karena dapat berdampak pada ibu maupun janin atau bayi.

Toksisitas

Efek negatif berbahaya yang timbul akibat dosis obat berlebihan atau interaksi antarobat, yang dapat menyebabkan gangguan serius hingga mengancam nyawa pasien. Contoh: Risiko toksisitas magnesium sulfat pada ibu hamil preeklamsia.

G. Daftar Pustaka

- Arcangelo, V. P., & Peterson, A. M. (2021). *Pharmacotherapeutics for advanced practice nurse prescribers* (5th ed.). F.A. Davis Company.
- Burchum, J. R., & Rosenthal, L. D. (2021). *Lehne's pharmacology for nursing care* (11th ed.). Elsevier.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Jordan, S. (2019). *Pharmacology for midwives: The evidence base for safe practice* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Katzung, B. G. (2021). *Basic & clinical pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- King, T. L., & Brucker, M. C. (2019). *Pharmacology for women's health* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., Alden, K. R., Olshansky, E. F., & Hockenberry, M. J. (2019). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier.

- McKenna, L., & Lim, A. G. (2020). Pharmacology in nursing and midwifery practice: Making a difference (3rd ed.). Elsevier Australia.
- Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2020). Rang & Dale's pharmacology (9th ed.). Elsevier.
- Schuiling, K. D., & Likis, F. E. (2022). Women's gynecologic health (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.

BAB 2

PRINSIP PEMBERIAN OBAT DAN CARA MENGATASI EFEK SAMPING OBAT

Pendahuluan

Pemberian obat adalah salah satu aspek utama dalam proses perawatan pasien yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, atau mengelola kondisi medis tertentu. Sebagai petugas kesehatan, penting untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip pemberian obat yang baik untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain memberikan obat sesuai dengan petunjuk medis, penanganan efek samping obat juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Obat-obatan yang diberikan untuk merawat penyakit atau kondisi medis tertentu dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap reaksi tubuh pasien terhadap obat yang diberikan sangat diperlukan. Efek samping yang timbul bisa berupa reaksi ringan, seperti mual atau pusing, hingga reaksi yang lebih serius, seperti reaksi alergi atau kerusakan organ.

Bab ini akan membahas tentang prinsip dasar pemberian obat serta penanganan efek samping obat. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami prinsip yang harus diterapkan dalam pemberian obat serta cara penanganan efek

samping dari obat. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi kebidanan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah 6 benar prinsip dasar pemberian obat, macam-macam rute pemberian obat, pengertian efek samping, jenis-jenis efek samping, faktor pendorong efek samping dan cara mengatasi efek samping.

Untuk memberikan gambaran lebih nyata terkait praktek tersebut, akan dilengkapi juga dengan studi kasus singkat tentang prinsip dan efek samping pemberian obat. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Intruksional Umum:

Setelah membaca bab ini, pembaca dapat memberikan obat sesuai dengan ketentuan dan memahami efek samping dari obat dalam pelayanan kebidanan.

Tujuan Intruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 6 benar prinsip dasar pemberian obat
2. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam rute pemberian obat
3. Mahasiswa mampu memahami pengertian efek samping
4. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis efek samping
5. Mahasiswa mampu memahami faktor pendorong efek samping

6. Mahasiswa mampu memahami cara mengatasi efek samping obat

Capaian Pembelajaran:

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan 6 benar prinsip dasar pemberian obat serta cara penanganan efek samping obat
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip kebidanan dalam skenario klinis.

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan kebidanan yang spesifik dan tepat, seperti penerapan 6 benar prinsip dasar pemberian obat, dan cara penanganan efek samping obat.

Afektif

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari prinsip dalam pemberian obat pada pasien macam-macam rute pemberian obat, pengertian efek samping, jenis-jenis efek samping, faktor pendorong efek samping dan cara mengatasi efek samping obat. Selain itu terdapat Latihan studi kasus terkait materi pembelajaran yang sudah di jabarkan.

A. Prinsip Pemberian Obat

Pemberian obat adalah salah satu prosedur yang paling sering dilakukan dalam layanan kesehatan, dan merupakan tanggung jawab yang sangat krusial dalam keperawatan. Kesalahan dalam pemberian obat dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi pasien. Oleh karena itu, ketelitian dalam pemberian obat sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan pasien tetap terjaga. Perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya harus dengan cermat mengikuti pedoman pemberian obat yang aman untuk menghindari risiko. Beberapa prinsip dasar dalam pemberian obat yang harus diperhatikan meliputi (Suryani & Permana, 2020; Utama et al., 2021):

1. Benar Pasien

Langkah pertama yang sangat penting dalam prinsip pemberian obat adalah benar pasien hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat yang bisa berbahaya, terutama jika obat diberikan pada pasien yang salah. Hal yang bisa dilakukan untuk

memastikan benar pasien adalah dengan memastikan identitas dengan tepat (nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis). Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menanyakan langsung dan memverifikasinya melalui gelang identitas pasien dan rekam medis. Menurut Joint Commission International (JCI) 2012, memastikan "Benar Pasien" sebelum pemberian obat merupakan bagian dari prosedur standar untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan. Meskipun penerapan prosedur yang tepat sangat penting, kesalahan identifikasi pasien bisa menyebabkan berbagai dampak yang merugikan. Beberapa dampak yang dapat timbul akibat kesalahan identifikasi dalam pengobatan meliputi *adverse events* (Kejadian Tidak Diharapkan/KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensi Cedera (KPC), dan Kejadian Tidak Cedera (KTC).

2. Benar Obat

Benar obat adalah salah satu indikator penting keberhasilan peran perawat sebagai kolaborator dalam tim kesehatan. Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tenaga medis lain, seperti dokter dan apoteker untuk memastikan bahwa dosis obat yang diberikan sesuai dengan resep yang telah ditentukan tanpa perubahan. Pasien mendapatkan obat berdasarkan dengan yang sudah diresepkan oleh dokter. Berikut adalah komponen-komponen perintah pengobatan yang harus ada dalam setiap perintah atau resep, baik itu yang

tertulis langsung maupun yang diberikan melalui telepon (dengan konfirmasi dokter dalam waktu 24 jam):

- a. Tanggal dan saat perintah ditulis
- b. Nama obat
- c. Dosis obat
- d. Rute pemberian
- e. Frekuensi pemberian
- f. Tanda tangan dokter atau pemberi asuhan kesehatan

Keamanan pasien dalam pemberian obat sangat bergantung pada ketelitian dan kehati-hatian perawat dalam menjalankan prosedur yang benar. Berikut merupakan Langkah penting dalam pemberian obat:

- a. Perawat bertanggung jawab dengan mengikuti perintah pengobatan yang sah dan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter.
- b. Menghindari kesalahan dengan membaca label obat minimal 3 kali untuk memastikan obat yang diberikan sudah sesuai yaitu saat melihat botol atau kemasan obat, sebelum menuang atau mengisap obat dan setelah menuang atau mengisap obat.
- c. Memeriksa kelengkapan perintah pengobatan
- d. Mengetahui alasan pemberian obat
- e. Memastikan Obat Obat yang Diberikan Benar: Ini termasuk memastikan nama obat, tanggal kedaluwarsa, dan dosis yang tepat sesuai resep dokter.

Jika ada keraguan atau kekurangan informasi dalam resep, perawat wajib menghubungi dokter untuk klarifikasi sebelum melanjutkan pemberian obat, demi

keselamatan pasien. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, risiko kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan, dan kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.

3. Benar Dosis

Menurut Vaughans, dalam penelitian yang dilakukan oleh Utama et al (2021) sebagai perawat, sangat penting untuk memastikan bahwa dosis obat yang diberikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasien. Hal ini membantu menghindari resistensi obat dan mencegah kesalahan lainnya, termasuk risiko serius seperti kehilangan nyawa pasien akibat dosis yang berlebihan. Langkah yang perlu diperhatikan perawat atau bidan dalam memastikan benar dosis adalah dengan memeriksa kembali label resep dan dosisnya. Menurut Suryani & Permana (2020), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan dosis obat antara lain:

- a. Perawat wajib memastikan bahwa pasien menerima dosis obat yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.
- b. Dosis yang diberikan harus berada dalam rentang yang aman sesuai dengan rekomendasi medis.
- c. Perawat harus berhati-hati dalam menghitung dosis obat yang akan diberikan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan obat, dosis yang tertera dalam resep, berat badan pasien (dalam satuan mg/kg berat badan/hari), dan jika perlu, meminta

bantuan perawat lain untuk memverifikasi perhitungan dosis sebagai langkah pengamanan ekstra.

- d. Penting untuk memperhatikan batas dosis yang disarankan untuk obat-obatan tertentu agar tidak melebihi dosis yang berisiko.

Selain itu dalam peraturan pemerintah juga di sebutkan dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang Keselamatan Pasien. Permenkes ini menerapkan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Salah satu aspek penting dalam permenkes ini adalah menekankan pentingnya penerapan prinsip "Benar Dosis" dalam pemberian obat oleh tenaga medis, terutama Perawat dan bidan. Dalam regulasi ini, diatur dengan jelas bahwa perawat harus memberikan obat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter, dan memastikan bahwa pemberian obat dilakukan dengan mematuhi prosedur yang benar untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*) (Permenkes RI, 2017). Langkah krusial yang bisa dilakukan dalam pemberian obat yang aman adalah dengan menggunakan alat standar untuk memastikan ketepatan dosis. Alat yang bisa digunakan seperti alat pembelah tablet, spuit atau sendok khusus, gelas ukur, serta pipet tetes yang digunakan untuk obat sediaan sirup (Aprilia et al., 2022).

4. Benar Waktu Pemberian

Perawat memiliki peran penting sebagai pendidik, yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai cara dan waktu yang tepat untuk mengonsumsi obat yang diberikan serta potensi dampak atau efek samping yang mungkin timbul setelah mengonsumsinya. Namun, sering kali peran ini kurang mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga banyak pasien yang bingung atau salah dalam mengonsumsi obat yang diberikan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kesalahan interpretasi terhadap petunjuk pada label obat, seperti "tiga kali sehari" (3x1), yang sering disalahartikan oleh pasien. Padahal, yang dimaksud dengan petunjuk tersebut adalah waktu atau interval yang tepat antara dosis, bukan jumlah kali konsumsi dalam sehari. Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan pengobatan tidak efektif dan bahkan kegagalan terapi. Aprilia et al (2022) menyebutkan dalam tulisannya bahwa Perawat harus melakukan pemeriksaan kecocokan waktu dan frekuensi pemberian obat sesuai dengan resep atau instruksi, dengan mempertimbangkan durasi kerja dan efektivitas obat. Ditegaskan bahwa jika obat harus diberikan pada interval waktu tertentu, maka tidak boleh memberikan obat lebih dari 30 menit setelah waktu yang ditentukan. Apabila pemberian obat melebihi 30 menit dari jadwal yang ditetapkan, bioavailabilitas (kemampuan obat untuk diserap dengan cepat ke dalam sirkulasi sistemik) dapat terpengaruh, yang berpotensi mengurangi efektivitas obat tersebut. Hal yang perlu

diperhatikan dalam waktu pemberian obat adalah sebagai berikut (Suryani & Permana, 2020):

- a. Obat diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- b. Waktu yang tepat adalah saat yang ditentukan untuk pemberian obat sesuai resep. Dosis obat harian diberikan pada waktu yang spesifik setiap harinya, seperti b.i.d (dua kali sehari), t.i.d (tiga kali sehari), q.i.d (empat kali sehari), atau q6h (setiap 6 jam), untuk menjaga kestabilan kadar obat dalam plasma. Obat dengan waktu paruh pendek harus diberikan beberapa kali dalam sehari dengan interval yang sesuai.
- c. Pemberian obat perlu memperhatikan waktu paruh ($t_{1/2}$) dari obat tersebut. Obat dengan waktu paruh panjang biasanya diberikan sekali dalam sehari, sementara obat dengan waktu paruh pendek diberikan beberapa kali sehari pada interval yang telah ditentukan.
- d. Waktu pemberian obat juga harus mempertimbangkan apakah obat tersebut harus diberikan sebelum makan, sesudah makan, atau bersamaan dengan makanan.
- e. Obat seperti kalium dan aspirin, yang dapat mengiritasi mukosa lambung, sebaiknya diberikan bersama makanan.
- f. Tanggung jawab perawat termasuk memastikan apakah pasien telah dijadwalkan untuk tes diagnostik, seperti tes darah puasa, yang dapat menjadi kontraindikasi dalam pemberian obat tertentu.

5. Benar Cara/Rute Pemberian Obat

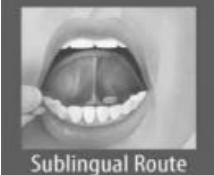
Manajemen obat merupakan elemen yang sangat penting dalam keberhasilan pengobatan pasien. Pengobatan dianggap berhasil ketika obat yang diterima pasien diberikan melalui rute yang sesuai dengan jenis obat tersebut. Perawat memastikan bahwa cara pemberian obat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mereka memverifikasi label atau kemasan obat, memeriksa kemampuan menelan pasien untuk terapi oral hingga memastikan obat benar-benar dikonsumsi. Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan keamanan maksimal kepada pasien selama proses pengobatan di rumah sakit. Suryani & Permana (2020) menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan rute pemberian obat antara lain:

- a. Proses penyerapan obat dalam tubuh harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan efektivitasnya.
- b. Sebelum memberikan obat oral, perawat perlu mengevaluasi kemampuan pasien dalam menelan.
- c. Saat memberikan obat secara parenteral, perawat harus menggunakan teknik aseptik yang sesuai.
- d. Obat harus diberikan pada lokasi yang tepat, dan perawat harus tetap bersama pasien hingga obat oral tertelan dengan sempurna.

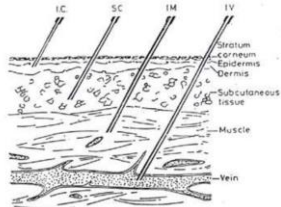
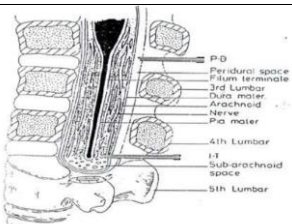
Obat dapat diberikan melalui berbagai rute, seperti inhalasi, rektal, topikal, parenteral, sublingual, dan peroral. Pemilihan rute pemberian yang paling tepat ditentukan

oleh tujuan kerja obat, sifat fisik dan kimiawi obat, kecepatan respon yang diinginkan, serta kondisi umum pasien (Nuryati, 2017). Berikut merupakan gambaran beberapa rute pemberian obat (Azizah et al., 2023):

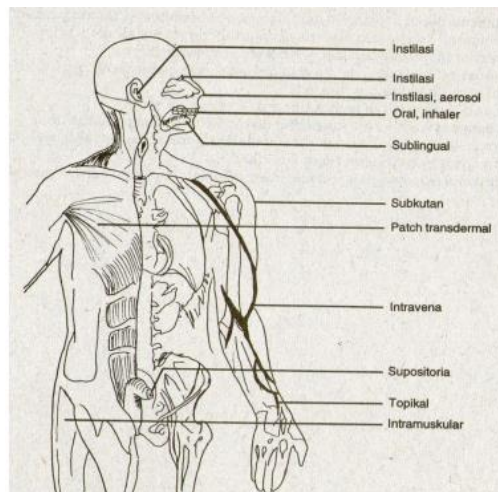
Tabel 2.1: Rute Pemberian Obat

ENTERAL (PER ORAL ATAU MELALUI MULUT)		
Oral	Ditelan	
Sub Lingual	Di bawah lidah	 Sublingual Route Pimple, Kudal, Sanap, & Murkute tahun 2022 dalam Azizah et al (2023)
Buccal	Rongga mulut	 Buccal Route Pimple, Kudal, Sanap, & Murkute tahun 2022 dalam Azizah et al (2023)

Tabel 2.2: Rute Pemberian Obat

PARENTERAL (INJEKSI)		
Intra Vena (IV)	Ke dalam pembuluh	 (Tungadi, 2017)
Intra Muskular (IM)	Ke dalam otot	
Sub Cutan (SC)	Ke bawah lapisan kulit	
Intra Cutan (IC)	Ke dalam lapisan kulit	
Intra Arteri (IA)	Ke dalam pembuluh arteri	
Intrathecal	Ke dalam rongga sub arachnoid	 (Tungadi, 2017)
TOPICAL		
Innunction	Digosok pada kulit	
Inhalation	Dihirup melalui hidung	

Topical (Rektal)	Melalui anus, pada kulit dan mukosa	 Doyle & McCutcheon tahun 2015 dalam Azizah et al (2023)
---------------------	---	--



**Gambar 2.1: Rute Pemberian Obat
(Noprianty et al., 2023)**

6. Benar Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu penatalaksanaan yang penting dilakukan Perawat/bidan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam

melaksanakan tugas atau asuhan yang diberikan tak terkecuali pada proses pemberian obat. Petugas kesehatan harus selalu melakukan dokumentasi secara lengkap dan tepat. Dokumentasi ini sangat berguna untuk memastikan bahwa pengobatan dilakukan dengan benar, dan untuk memantau respon klien terhadap obat yang diberikan. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam dokumentasi adalah nama pasien, nama obat, dosis obat, rute pemberian, waktu pemberian, respon terhadap obat dan siapa yang memberikan obat. Pencatatan yang akurat sangat penting untuk referensi di masa depan, serta untuk mendukung keputusan medis yang lebih tepat jika ada perubahan dalam kondisi pasien. Pendokumentasian harus segera dilakukan setelah obat selesai diberikan. Jika pasien menolak untuk mengonsumsi obat atau jika pemberian obat tidak memungkinkan, maka hal tersebut juga wajib dicatat dalam dokumentasi (Nuryati, 2017; Yunique et al., 2024).

B. Cara Mengatasi Efek Samping (ESO) / Adverse Drug Reactions (ADRs)

1. Pengertian Efek Samping

Efek samping obat (ESO) adalah reaksi yang tidak diinginkan dan merugikan yang terjadi setelah mengonsumsi obat, meskipun obat tersebut digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan untuk tujuan tertentu seperti pencegahan, diagnosis, atau pengobatan. Efek samping ini bisa berbeda-beda tergantung pada

jenis obat, dosis, cara penggunaan, dan respons tubuh setiap individu (Anjani et al., 2023; Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020). Efek samping obat merujuk pada efek yang tidak menjadi tujuan utama dari pengobatan, atau yang sering disebut sebagai efek sekunder. Efek samping ini bisa bermanfaat, mengganggu, atau bahkan merugikan, tergantung pada kondisi pasien, dosis yang diberikan, dan jenis obat yang digunakan (Bone & Usiono, 2023). Selain itu juga dijelaskan bahwa ESO merupakan salah satu reaksi yang timbul akibat dari penggunaan obat yang bisa meningkatkan kejadian penyakit lain hingga dengan kematian jika tidak ditangani dengan baik (Lathifah et al., 2022). ESO kadangkalanya tidak dapat dihindarkan terutama jika obat digunakan dalam dosis yang lebih tinggi dari yang dianjurkan atau dalam jangka panjang. Selain itu ESO pula dapat timbul sebagai lanjutan dari efek samping utama obat tersebut. Misalnya penggunaan obat fenobarbital yang memberikan nuansa mengantuk saat digunakan untuk meredakan pasien epilepsy (Anwar et al., 2023).

2. Jenis-Jenis Efek Samping

Efek samping obat umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis utama (Wardani, 2021):

a. Efek Samping Yang Dapat Diperkirakan

Efek Samping Obat yang Dapat Diperkirakan (Expected Adverse Drug Reaction) adalah reaksi yang diharapkan berdasarkan pengetahuan tentang obat,

sifat farmakologinya, dan pengalaman klinis sebelumnya. Meskipun demikian, efek samping ini bisa mencakup reaksi yang tidak teramati sebelumnya atau yang baru ditemukan, yang penting untuk dilaporkan agar informasi tersebut bisa segera diketahui dan ditangani oleh regulator, investigator, atau pihak medis lainnya (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020). Efek samping yang tidak dapat diperkirakan meliputi:

- 1.) Efek toksik (efek farmakologi yang berlebihan). Efek toksik terjadi ketika obat diberikan dalam dosis yang terlalu tinggi, melebihi kapasitas tubuh untuk menoleransi atau mengelola obat tersebut. Contoh dari efek ini adalah adanya kerusakan pada organ tubuh seperti kerusakan hati atau gangguan ginjal.
- 2.) Gejala penghentian obat atau *withdrawal syndrome* terjadi ketika seseorang yang telah menggunakan obat secara tiba-tiba menghentikan penggunaan obat tersebut. Penghentian obat yang mendadak dapat menyebabkan tubuh mengalami gejala yang mirip dengan gejala penyakit asli atau semula. Contoh dari gejala penghentian obat adalah gemetar/tremor, nyeri otot, kelelahan, mual muntah, insomnia, halusinasi, mudah berkeringat dan kejang.
- 3.) Efek samping yang tidak berupa efek farmakologi utama adalah efek yang terjadi akibat penggunaan obat dan sering kali dapat diperkirakan berdasarkan

penelitian dan pengujian klinis yang dilakukan sebelum obat dipasarkan dan digunakan oleh pasien. Pada umumnya, efek samping ini bersifat ringan dan dapat diprediksi, tetapi kejadian efek sampingnya mungkin cukup tinggi misalnya Rasa kantuk pada penggunaan antihistamin dan lain sebagainya.

b. Efek Samping Yang Tidak Dapat Diperkirakan

Efek samping yang tidak dapat diperkirakan disebut juga efek samping tidak terduga (Unexpected Adverse Drug Reaction). Efek samping ini merupakan reaksi merugikan yang tidak tercatat dalam informasi produk yang disetujui oleh badan pengawas (BPOM), atau yang tidak dapat diperkirakan berdasarkan karakteristik obat tersebut. Kejadian semacam ini harus segera dilaporkan hingga pembaruan informasi produk dapat segera dilakukan (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020). Jenis-jenis yang mungkin timbul adalah sebagai berikut (Bawono, 2011):

- 1.) Reaksi Alergi. Reaksi alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh merespons suatu obat sebagai benda asing yang berbahaya, padahal sebenarnya obat tersebut tidak berbahaya. Ini memicu reaksi imunologis yang menyebabkan efek samping. Contoh reaksi yang timbul dari alergi seperti demam yang tidak tinggi dan akan hilang dengan sendirinya saat obat dihentikan. Selain itu ada pula

gangguan pernafasan, reaksi alergi dapat berkisar dari ringan seperti ruam hingga berat seperti anafilaksis yang mengancam nyawa.

- 2.) Reaksi pada faktor genetik. Faktor ini memainkan peran besar dalam bagaimana tubuh merespons obat. Beberapa individu mungkin memiliki variasi genetik yang membuat tubuh mereka lebih sensitif terhadap obat tertentu atau lebih rentan terhadap efek samping yang berlebihan. Ini adalah alasan mengapa efek samping bisa lebih serius pada beberapa orang dibandingkan yang lain.
- 3.) Reaksi Idiosinkratik. Reaksi ini adalah reaksi yang tidak lazim, tidak diharapkan, atau aneh, yang tidak dapat dijelaskan atau diperkirakan mengapa efek ini bisa terjadi. Reaksi ini sering kali tidak terkait dengan dosis obat atau dengan mekanisme farmakologis yang diketahui.

3. Faktor Pendorong Efek Samping Obat

Efek samping obat dapat terjadi karena adanya interaksi rumit antara obat dan sistem biologis tubuh yang bervariasi antar individu. Faktor pendorong dan pendukung terjadinya efek samping obat adalah sebagai berikut (Bone & Usiono, 2023):

- a. Faktor pasien, atau faktor intrinsik, merujuk pada karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh individu itu sendiri meliputi:
 - 1.) Usia. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap respons tubuh pada obat dan potensi timbulnya

efek samping, terlebih pada usia anak-anak (khususnya bayi) dan lansia. Pada anak sistem metabolisme yang belum matang sempurna sehingga meningkatkan risiko efek samping. Pada lansia risiko efek samping meningkat karena fungsi tubuh secara keseluruhan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.

- 2.) Genetik dan kecenderungan energi. Pada beberapa orang yang memiliki kelainan genetik tertentu akan mempengaruhi cara tubuh mereka memetabolisme atau merespons obat. Hal ini dapat menyebabkan efek farmakologi yang berlebihan atau tidak diinginkan dan meningkatkan risiko efek samping. Selain itu genetik juga bisa mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengalami alergi terhadap obat. Misalnya, sekitar 1-5% orang yang mengonsumsi penisilin dapat mengalami reaksi alergi, mulai dari ruam ringan hingga reaksi anafilaksis yang serius.
- 3.) Penyakit yang diderita. Seseorang dengan penyakit tertentu membutuhkan perhatian lebih, dalam pemilihan dosis dan jenis obat. Hal ini karena penyakit yang diderita dapat memengaruhi cara tubuh memproses obat dan meningkatkan risiko efek samping yang serius. Contohnya untuk pasien dengan gangguan hati atau ginjal beberapa obat yang dikonsumsi akan menimbulkan respons serius sehingga penggunaan obat harus disesuaikan

dengan pertimbangan dokter. Hal ini dilakukan agar dokter dapat meresepkan obat dengan dosis yang tepat, memilih obat yang lebih aman, dan memberikan instruksi pengobatan yang lebih spesifik untuk mencegah efek samping yang berbahaya.

b. Faktor intrinsik obat merujuk pada sifat-sifat internal obat itu sendiri yang dapat mempengaruhi potensi untuk menimbulkan efek samping atau reaksi pada pasien seperti:

- 1.) Pemilihan obat. Setiap obat memiliki mekanisme kerja yang unik serta dapat mempengaruhi tubuh dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan efek samping yang mungkin timbul karena bisa berbeda-beda tergantung pada jenis obatnya.
- 2.) Jangka waktu penggunaan obat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan karena Beberapa obat, meskipun efektif dalam mengobati kondisi medis, dapat menyebabkan efek samping yang serius jika digunakan terlalu lama atau dalam dosis yang tinggi. Salah satu contohnya adalah penggunaan parasetamol yang sering digunakan untuk mengatasi rasa sakit ringan hingga sedang atau sebagai penurun demam. Namun, jika digunakan dalam dosis tinggi dalam jangka panjang, parasetamol dapat menyebabkan

kerusakan hati yang serius, yang dikenal dengan istilah hepatotoksik.

- 3.) Interaksi obat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Interaksi obat terjadi ketika dua atau lebih obat yang dikonsumsi secara bersamaan saling mempengaruhi satu sama lain, yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan atau bahkan mengurangi efektivitas obat. Contohnya kombinasi antara obat hipertensi inhibitor ACE dengan diuretik potasium-sparing (spironolakton) dapat menyebabkan hiperkalemia.

4. Cara Mengatasi Efek Samping

Pada dasarnya ketika terjadi efek samping yang diketahui atau dicurigai, langkah pertama yang perlu diambil adalah menghentikan penggunaan obat yang diduga penyebab efek samping tersebut. Melanjutkan pengobatan dengan menambah dosis atau mengobati efek samping dengan obat lain tanpa menghentikan obat yang dicurigai justru bisa memperburuk kondisi pasien dan tidak efektif. Tindakan yang tepat tergantung pada jenis dan kondisi klinis pasien (Noprianty et al., 2023). Berikut beberapa jenis obat yang sering digunakan adalah sebagai berikut (Anwar et al., 2023):

a. Uterotonika

Uterotonika adalah obat yang digunakan untuk merangsang kontraksi otot rahim (uterus), terutama setelah melahirkan, untuk membantu mengurangi perdarahan pasca persalinan atau untuk mengontrol

kontraksi rahim pada keadaan tertentu. Obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi atonia uteri (keadaan di mana rahim tidak berkontraksi setelah persalinan, yang dapat menyebabkan perdarahan berat) dan untuk mempercepat proses kelahiran. Contoh obat ini meliputi metil ergometrin, oksitosin, ergometrin, dan misoprostol/prostaglandin. Menurut Siswosudarmo tahun 2009 dalam Eka Nur Fatmawati et al (2024) Penggunaan uterotonika memiliki potensi efek samping, baik yang ringan maupun yang serius. Untuk reaksi ringan yang dapat timbul dapat berupa mual, muntah, ruam kulit, pembekakan mulut, sesak nafas dan masalah pembekuan darah. Sedangkan efek samping serius yang mungkin terjadi seperti fetal distress, asfiksia, dan Intra Uterine Fatal Death (IUFD). Selain itu, penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kontraksi rahim yang berlebihan atau tidak berkontraksi sama sekali, yang bisa berujung pada ruptur uteri. Untuk mengatasi efek samping yang ditimbulkan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.) Pemantauan terhadap efek samping diperlukan selama penggunaan metil ergometrin.
- 2.) Penggunaan obat ini harus mengikuti dosis yang telah ditentukan.
- 3.) Jika efek samping terlalu parah, dapat diatasi reaksi mual muntah dengan pemberian obat lain, seperti obat antimual

- 4.) Kurangi dosis untuk melindungi saluran pencernaan.
- 5.) Untuk reaksi diare biasanya akan sembuh dalam waktu satu minggu.
- 6.) Menghentikan pengobatan untuk mengurangi efek samping yang timbul

b. Obat analgesik

Obat analgesik adalah jenis obat yang digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa sakit tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran pada seseorang. Obat umum yang masuk dalam kategori obat analgesik adalah asam mefenamat dan natrium diklofenak. Obat analgesik menimbulkan beberapa efek samping. Jika dilihat dari sistem pencernaan efek samping yang mungkin timbul adalah mual, muntah, gangguan saluran pencernaan dan sakit bagian abdominal. Dari sistem saraf efek samping yang ditimbulkan berupa rasa kantuk, pusing, penglihatan mata kabur dan insomnia. Terakhir obat ini dapat menimbulkan ruam pada kulit. Untuk cara penanganannya dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut (Wahyuni, 2018):

- 1.) Sebaiknya dikonsumsi setelah makan.
- 2.) Jangan digunakan lebih dari 7 hari atau melebihi dosis yang dianjurkan, kecuali sesuai anjuran dokter.
- 3.) Penderita gangguan fungsi ginjal atau jantung harus mendapatkan perhatian khusus.

4.) Hati-hati dalam penggunaannya pada wanita hamil dan menyusui.

5.) Jika terjadi perdarahan atau ulkus, penggunaan obat harus dihentikan.

c. Obat antipiretika

Obat antipiretika adalah jenis obat yang digunakan untuk menurunkan demam atau penurunan suhu tubuh yang meningkat, biasanya akibat infeksi atau peradangan. Contoh dari obat ini adalah paracetamol, ibuprofen dan asam asetilsalisilat. Reaksi dari penggunaan obat antipiretika dalam penggunaan dosis besar dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi hati, iritasi pada lambung, serta gejala mual dan muntah. Penggunaan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan perdarahan dan tukak pada lambung. Cara mengatasi efek samping obat antipiretika dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Wahyuni, 2018):

1.) Disarankan untuk mengonsumsi obat ini setelah makan atau bersamaan dengan makanan.

2.) Simpan obat ini di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak untuk menghindari penggunaan yang salah.

3.) Perhatikan dengan cermat penggunaan obat ini pada individu dengan gangguan fungsi ginjal dan hati.

C. Latihan

Pilihan Ganda

Silahkan kerjakan latihan soal berikut ini untuk mengasah pemahaman anda sesuai materi dalam BAB ini. Pilihlah salah satu option (a,b,c,d,e) yang merupakan jawaban benar!

1. Pemberian obat dengan cara menyuntikkan ke bagian *subcutaneous tissue* adalah ...
 - a. Intra Vena (IV)
 - b. Intrathecal
 - c. Pemberian Oral
 - d. Buccal
 - e. Sub Cutan (SC)
2. *Medication error* dapat terjadi jika penerapan prinsip pemberian obat tidak dilakukan dengan benar, yaitu pada prinsip bagian ...
 - a. Benar obat
 - b. Benar dosis
 - c. Benar pasien
 - d. Benar waktu
 - e. Benar dokumentasi
3. Langkah utama ketika adanya kecurigaan efek samping obat adalah ...
 - a. Menghentikan penggunaan obat yang diduga penyebab efek samping tersebut
 - b. Melanjutkan pengobatan sampai sembuh
 - c. Pengobatan terus dilakukan dengan menambah obat lain
 - d. Menghubungi ambulance

- e. Melakukan konsultasi
- 4. Kematian janin dalam kandungan merupakan salah satu efek samping dari jenis obat ...
 - a. Paracetamol
 - b. Analgesik
 - c. Antipiretika
 - d. Uterotonika
 - e. Tablet FE
- 5. Apa yang dimaksud dengan efek samping *withdrawal syndrome* ?
 - a. Efek samping yang terjadi karena gejala penghentian obat yang tiba-tiba
 - b. Efek samping yang tidak tercatat dalam informasi produk
 - c. Efek samping yang tidak dapat di perkirakan
 - d. Efek samping yang terjadi karena adanya pemberian obat dosis tinggi
 - e. Efek samping yang terjadi karena memiliki genetik sensitive

Essay !

1. Seorang wanita usia 27 tahun diagnosis medis hyperemesis gravidarum. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu menyatakan mual muntah setiap kali makan dan minum sejak seminggu belakangan, kadang disertai dengan pusing sehingga ibu merasa cemas. HPHT 2 Desember 2024. Tekanan darah ibu 100/80, pernafasan 20x/menit, nadi 100x/menit suhu 36,5°C, TB 157cm, dengan berat badan ibu 50kg dan lila 22cm.

pemeriksaan penunjang yang dilakukan Hb dengan hasil 11,5 gr/dl. Terapi yang diberikan kepada ibu adalah injeksi ondancentron 1 ampul/8 jam, B Com Kapsul 3x1, Donperidon 1x1, Antishitamnim 2x1 dan Sangobion 1x1. Selain itu memberikan edukasi pada ibu untuk makan porsi kecil (sedikit) namun sering. Tuliskan data yang harus ada dalam prinsip pemberian obat bagian benar dokumentasi !

2. Sebutkan faktor pendorong dari efek samping obat !
3. Sebutkan dan berikan contoh dari jenis-jenis efek samping obat !
4. Jelaskan macam rute pemberian obat !
5. Jelaskan perbedaan benar obat dan benar dosis dalam prinsip dasar pemberian obat !

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban : E. Sub Cutan (SC)
Pembahasan : Rute pemberian obat dibagi menjadi tiga yaitu enteral, parenteral dan topical. Untuk Sub Cutan (SC) merupakan salah satu cara pemberian obat dengan parenteral (injeksi) yaitu dengan memasukkan obat kebagian bawah lapisan kulit (*subcutaneous tissue*).
2. Kunci Jawaban : B. Benar Dosis
Pembahasan : Tenaga kesehatan harus memberikan obat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter, dan memastikan bahwa pemberian obat dilakukan dengan mematuhi prosedur

yang benar untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error).

3. Kunci Jawaban : A. Menghentikan penggunaan obat yang diduga penyebab efek samping tersebut.

Pembahasan : Pada dasarnya ketika terjadi efek samping yang diketahui atau dicurigai, langkah pertama yang perlu diambil adalah menghentikan penggunaan obat yang diduga penyebab efek samping tersebut. Melanjutkan pengobatan dengan menambah dosis atau mengobati efek samping dengan obat lain tanpa menghentikan obat yang dicurigai justru bisa memperburuk kondisi pasien dan tidak efektif. Tindakan yang tepat tergantung pada jenis dan kondisi klinis pasien

4. Kunci Jawaban : D. Uterotonika

Pembahasan : Penggunaan uterotonika memiliki potensi efek samping, baik yang ringan maupun yang serius. Untuk reaksi ringan yang dapat timbul dapat berupa mual, muntah, ruam kulit, pembekakan mulut, sesak nafas dan masalah pembekuan darah. Sedangkan efek samping serius yang mungkin terjadi seperti fetal distress, asfiksia, dan Intra Uterine Fatal Death (IUFD). Selain itu, penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kontraksi rahim yang berlebihan atau tidak berkontraksi sama sekali, yang bisa berujung pada ruptur uteri.

5. Kunci Jawaban : A. Gejala penghentian obat yang tiba-tiba

Pembahasan : efek samping obat dibagi menjadi 2 jenis utama yaitu efek samping yang dapat diperkirakan dan efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Gejala penghentian obat atau *withdrawal syndrome* merupakan salah satu efek samping yang dapat diperkirakan. Hal ini terjadi ketika seseorang yang telah menggunakan obat secara tiba-tiba menghentikan penggunaan obat tersebut. Penghentian obat yang mendadak dapat menyebabkan tubuh mengalami gejala yang mirip dengan gejala penyakit asli atau semula. Contoh dari gejala penghentian obat adalah gemetar/tremor, nyeri otot, kelelahan, mual muntah, insomnia, halusinasi, mudah berkeringat dan kejang.

D. Rangkuman Materi

Pemberian obat adalah prosedur penting dalam layanan kesehatan yang memerlukan ketelitian untuk menjaga keselamatan pasien. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat serius. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mengikuti pedoman pemberian obat yang aman, dengan memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Benar Pasien : Memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat
- b. Benar Obat : Memastikan obat yang diberikan sesuai dengan resep yang diberikan dokter
- c. Benar Dosis : Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan yang ditentukan dan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan pasien

- d. Benar Waktu : Memberikan obat pada waktu yang telah ditentukan.
- e. Benar Cara : Memberikan obat dengan metode yang benar (oral, injeksi, dll).
- f. Benar dokumentasi : melakukan dokumentasi terkait pemberian obat secara lengkap dan tepat (nama pasien, nama obat, dosis obat, rute pemberian, waktu pemberian, respon terhadap obat dan siapa yang memberikan obat)

Kesalahan dalam penerapan prinsip pemberian obat dapat menyebabkan masalah serius, salah satunya efek samping obat. Efek samping ini bisa berupa reaksi tubuh yang tidak diinginkan, yang dapat memperburuk kondisi pasien atau menyebabkan komplikasi baru. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memantau respon pasien terhadap obat dan memastikan pemberian obat dilakukan dengan tepat sesuai pedoman yang ada. Efek samping obat dibagi menjadi dua jenis utama.

Pertama, efek samping yang dapat diperkirakan. Efek samping ini adalah reaksi yang diharapkan berdasarkan pengetahuan tentang obat, sifat farmakologinya, dan pengalaman klinis sebelumnya. Efek samping yang tidak dapat diperkirakan meliputi: efek toksik, *withdrawal syndrome*, dan efek samping yang tidak berupa efek farmakologi utama. Yang kedua adalah efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Efek samping ini merupakan reaksi merugikan yang tidak tercatat dalam informasi produk yang disetujui oleh badan pengawas (BPOM), atau yang tidak dapat diperkirakan berdasarkan

karakteristik obat tersebut. Jenis-jenis yang mungkin timbul dari efek samping ini adalah reaksi alergi, reaksi pada faktor genetic, dan reaksi idiosinkratik.

Efek samping obat dapat terjadi karena adanya interaksi rumit antara obat dan sistem biologis tubuh yang bervariasi antar individu. Faktor dari pasien dan faktor intrinsic obat menjadi salah satu faktor pendorong dan pendukung terjadinya efek samping obat. Pada dasarnya ketika terjadi efek samping yang diketahui atau dicurigai, langkah pertama yang perlu diambil adalah menghentikan penggunaan obat yang diduga penyebab efek samping tersebut. Melanjutkan pengobatan dengan menambah dosis atau mengobati efek samping dengan obat lain tanpa menghentikan obat yang dicurigai justru bisa memperburuk kondisi pasien dan tidak efektif. Tindakan yang tepat tergantung pada jenis dan kondisi klinis pasien.

E. Glosarium

JCI	: <i>Joint Commission Internasional</i>
KTD	: Kejadian Tidak Diharapkan
KNC	: Kejadian Nyaris Cedera
KPC	: Kejadian Potensi Cedera
KTC	: Kejadian Tidak Cedera
IV	: <i>Intra Vena</i>
IM	: <i>Intra Muskular</i>
SC	: <i>Sub Cutan</i>
IC	: <i>Intra Cutan</i>
IA	: <i>Intra Arteri</i>

b.i.d: Dua kali sehari
t.i.d : Tiga kali sehari
q.i.d: Empat kali sehari
q6h : Setiap 6 jam
ESO : Efek samping obat
ADRs : *Adverse Drug Reactions*
BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan
ACE : *Angiotensin-converting enzyme*

F. Daftar Pustaka

- Anjani, B. L. P., Rahmawati, C., Furqoni, N., Nurbaety, B., Wahid, A. R., Hati, M. P., Gunawan, P. G. S., & Pradiningsih, A. (2023). Edukasi Kejadian Efek Samping Obat Pada Masyarakat Di Dusun Mapong Desa Jurang Jaler, Lombok Tengah. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 1351. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.15511>
- Anwar, K. K., Dwiaini, I., Sarasmita, M. A., Bagiastara, I. nyoman, Hasanah, N., Yuhara, N. A., Wati, I., Dewi, S. R., Setyawati, N. F., Goretik, M., & Astuti, A. D. W. (2023). Farmakologi Kebidanan. In A. Jabbar, M. A. Sarasmita, & L. Kardin (Eds.), *CV. Eureka Media Aksara* (Pertama). CV. Eureka Media Aksara.
- Aprilia, N., Rachmah, & Yullyzar. (2022). Prinsip Tujuh Benar Pemberian Obat: Suatu Studi Kasus. *JIM FKep*, 1, 1–8. <https://jim.usk.ac.id>
- Azizah, L. N., Anwar, T., Nastiti, A. D., Muhalla, H. I., Zuhroidah, I., Dwipayanti, P. I., Sudrajat, A., & Puspitasari, R. A. H. (2023). BUKU AJAR FARMAKOLOGI KEPERAWATAN. In P. I. Daryaswanti (Ed.), *PT. Sonpedia Publishing*

Indonesia (Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<http://repository.stikesrspadgs.ac.id/2010/1/A231%2C%20BUKU%20AJAR%20FARMAKOLOGI%20KEPERAWATAN%2C%20ISBN%20978-623-8634-83-5%2C%20%2C%20Terbit%20Juni%202024%2C%20Sonpedia%20Publishing%20Indonesia%281%29.pdf>

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). Modul Farmakovigilans Untuk Tenaga Profesional Kesehatan Proyek "Ensuring Drug and Food Safety." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI*, 29–36.

Bawono, A. (2011). Kontribusi Religiusitas dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Konsumsi. *Jurnal Muqtasid*, 2, 76–77.

Bone, N. R., & Usiono. (2023). Systematic Literature Review: Efek Samping Obat Pada Kesehatan Tubuh. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 31030–31034.

Eka Nur Fatmawati, Ratna Mildawati, Yuneka Saristiana, Fendy Prasetyawan, & Faisal Akhmal Muslikh. (2024). Evaluasi Efektifitas Penggunaan Uterotonika Misoprostol pada Induksi Persalinan Kehamilan Postterm. *Jurnal Informatika Dan Kesehatan*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.35473/ikn.v1i1.3023>

Lathifah, N., Yuwindry, I., & Zulfadhilah, M. (2022). Pengaruh Efek Samping Obat Terhadap Kepatuhan Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner Di Rsud Brigjend H.Hasan Basry Hulu Sungai Selatan. *Journal Pharmaceutical Care and Sciences*, 3(1), 38–44. <https://doi.org/10.33859/jpcs.v3i1.216>

Noprianty, R., Mirwanti, R., Sakti, B., Juwariyah, S., Haeriyah,

- yayi S., Rahayu, S. M., Bagus, L. S., Hertini, R., Sandra, Vitniawati, V., Hutagalung, R., Nurlinawati, Khotimah, N. I. H. H., Indra, R. L., Yuningsih, A., Andriana, N., Djajanti, C. W., & Sihombing, F. (2023). Farmakologi Keperawatan. In F. Sihombing (Ed.), *Eureka Media Aksara*. CV. Eureka Media Aksara. https://repo.ftp.ac.id/id/eprint/638/22/23-09-151-EBOOK-Buku_Ajar_Farmakologi_Keperawatan.pdf
- Nuryati. (2017). Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK). In *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia* (Pertama). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://perinkes.fkm.univetbantara.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/FARMAKOLOGI-RMIK_FINAL_SC_26_10_2017.pdf
- Permenkes RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. In *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017*. <http://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2017/PERMENKES/permenkes-11-2017.pdf>
- Suryani, L., & Permana, L. (2020). Peningkatan Perilaku Perawat Melalui Pengetahuan Dalam Menjalankan Prinsip Pemberian Obat Dua Belas Benar. *Journal of Health Science*, *V*(li), 79–85.
- Tungadi, R. (2017). Teknologi Sediaan Steril. In *Sagung Seto*. <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Praktikum-Teknologi-Sediaan-Steril-Komprehensif.pdf>

- Utama, B. P., Purwandari, R., & Kurniawan, D. E. (2021). Pemberian Obat Menggunakan Prinsip Enam Benar di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 9(3), 454. <https://doi.org/10.20527/dk.v9i3.8720>
- Wahyuni, C. (2018). Farmakologi Kebidanan. In *Egc*.
- Wardani, H. (2021). Farmakologi Kebidanan. In Sumarni (Ed.), *CV. Cahaya Bintang Cemerlang* (Pertama). CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Yunike, Jawiah, Rehana, & Astuti, V. (2024). Buku Ajar Farmakologi Dalam Konteks Keperawatan. In I. Kusumawaty (Ed.), *Litnis*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/177/1/22.FARMAKOLOGI I DALAM KONTEKS KEPERAWATAN.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/177/1/22.FARMAKOLOGI%20DALAM%20KONTEKS%20KEPERAWATAN.pdf)

BAB 3

ETIKA PEMBERIAN OBAT DAN TERAPI KOMPLEMENTER DALAM ASUHAN KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pemberian obat serta mampu mengintegrasikan terapi komplementer dalam asuhan kebidanan secara aman, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah terbaru.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan mengevaluasi prinsip etika dalam pemberian obat serta mampu menerapkan terapi komplementer secara bijaksana dalam praktik kebidanan sesuai kebutuhan pasien.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan prinsip dasar etika dalam pemberian obat.
- Mengidentifikasi tanggung jawab profesional bidan dalam pemberian obat.
- Menilai keamanan dan efektivitas penggunaan obat dalam berbagai kondisi kebidanan.

- Memahami konsep dasar dan jenis-jenis terapi komplementer yang relevan dalam asuhan kebidanan.
- Mengintegrasikan terapi komplementer dengan pengobatan konvensional berdasarkan prinsip evidence-based practice.

Pendahuluan

Pemberian obat dan pemanfaatan terapi komplementer dalam praktik kebidanan merupakan aspek penting yang memerlukan pemahaman mendalam tentang etika dan prinsip dasar pengobatan. Etika dalam pemberian obat berkaitan erat dengan tanggung jawab profesional seorang bidan dalam menjamin keselamatan pasien serta memastikan pasien mendapatkan informasi yang lengkap mengenai terapi yang akan dijalani. Sementara itu, terapi komplementer, sebagai alternatif pendukung terapi medis konvensional, semakin diminati karena dianggap lebih aman dan holistik. Namun demikian, terapi ini harus diterapkan berdasarkan bukti ilmiah agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan.

A. Etika dalam Pemberian Obat

Etika dalam pemberian obat adalah salah satu aspek penting dalam praktik kebidanan. Sebagai tenaga kesehatan profesional, bidan bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan pasien. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam pemberian obat harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang jelas dan terintegrasi dengan nilai moral serta profesionalisme. Etika tidak hanya membimbing tindakan klinis, tetapi juga mencakup komunikasi dan hubungan terapeutik dengan pasien.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama yang wajib diperhatikan dalam praktik pemberian obat oleh bidan:

1. Otonomi Pasien

Otonomi pasien adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap pasien berhak untuk mengambil keputusan secara mandiri mengenai kesehatannya setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas dari tenaga kesehatan.

a. Hak Informasi Lengkap

Pasien berhak menerima penjelasan yang jelas, jujur, dan mudah dipahami tentang obat yang akan diberikan. Informasi yang disampaikan harus mencakup:

- 1) Indikasi obat, yaitu tujuan atau alasan mengapa obat tersebut diberikan.

- 2) Dosis dan aturan pemakaian, termasuk cara minum, frekuensi, serta durasi penggunaan obat.
- 3) Efek samping potensial, yaitu risiko dan efek negatif yang mungkin muncul dari penggunaan obat.
- 4) Alternatif terapi lain yang tersedia selain obat yang ditawarkan, termasuk keuntungan dan risikonya.

b. Persetujuan Tindakan

Setelah memperoleh informasi tersebut, pasien harus diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun. Pasien juga berhak untuk menolak atau meminta alternatif pengobatan yang tersedia.

2. Beneficence (Berbuat Baik)

Prinsip beneficence mengharuskan bidan untuk senantiasa bertindak dengan tujuan utama memberikan manfaat maksimal kepada pasien melalui pemberian obat dan intervensi terapeutik lainnya.

a. Tujuan Terapi

Pengobatan yang diberikan harus bertujuan untuk:

- 1) Memperbaiki kondisi kesehatan pasien.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit.
- 3) Mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan.

b. Pemilihan Obat yang Tepat

Bidan wajib memastikan bahwa obat yang dipilih adalah yang terbaik sesuai dengan kondisi klinis pasien berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based medicine).

Pemilihan harus mempertimbangkan efektivitas, keamanan, biaya, serta kemudahan akses pasien terhadap obat tersebut.

c. **Monitoring Efektivitas**

Setelah obat diberikan, bidan wajib memonitor perkembangan pasien secara rutin untuk memastikan bahwa tujuan terapi tercapai. Jika hasil tidak optimal, maka intervensi tambahan atau penggantian terapi harus dipertimbangkan.

3. Non-maleficence (Tidak Merugikan):

Prinsip non-maleficence menegaskan kewajiban bidan untuk tidak memberikan pengobatan yang dapat membahayakan pasien atau menyebabkan risiko yang melebihi manfaat terapi yang diberikan.

a. **Evaluasi Risiko-Manfaat**

Sebelum memberikan obat, bidan wajib melakukan evaluasi mendalam mengenai risiko dan manfaat dari obat tersebut. Pengobatan harus dihindari jika risiko efek samping atau komplikasi lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh pasien.

b. **Pencegahan Reaksi Obat**

Bidan harus melakukan langkah preventif dalam mencegah terjadinya efek samping yang serius dengan:

- 1) Memastikan dosis yang tepat dan aman.
- 2) Mengidentifikasi alergi atau kontraindikasi terhadap obat sebelum pemberian.

- 3) Memberikan edukasi kepada pasien tentang tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan.
- c. Minimalkan Interaksi Obat

Sebelum memberikan obat, bidan harus memastikan tidak ada interaksi negatif dengan obat-obat lain yang sedang dikonsumsi oleh pasien, sehingga meminimalkan risiko komplikasi.

4. Justice (Keadilan)

Prinsip keadilan menekankan perlunya perlakuan yang adil, merata, serta tanpa diskriminasi dalam pemberian obat dan layanan kesehatan kepada seluruh pasien, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, atau faktor lainnya.

a. Non-diskriminatif

Bidan wajib memastikan bahwa seluruh pasien mendapatkan pengobatan yang sama kualitasnya berdasarkan kebutuhan medis masing-masing. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses obat maupun kualitas pelayanan yang diberikan.

b. Distribusi Obat yang Adil

Bidan perlu memastikan bahwa setiap pasien memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pengobatan yang dibutuhkan. Kondisi yang sama harus mendapat perlakuan medis yang setara pula, dan setiap keputusan harus didasarkan pada kebutuhan

klinis, bukan pada pertimbangan pribadi atau keuntungan finansial semata.

c. **Pertimbangan Sosial-Ekonomi**

Dalam memberikan rekomendasi terapi obat, bidan juga perlu mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi pasien agar pengobatan yang diberikan benar-benar dapat dijangkau oleh pasien dan efektif dalam jangka panjang.

B. Tanggung Jawab Profesional Bidan

Dalam melaksanakan tugasnya, bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas dari segi etika profesional, hukum, dan standar praktik kebidanan. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, kualitas layanan, serta perlindungan hak pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan, termasuk dalam hal pemberian obat. Berikut adalah uraian mendalam mengenai tanggung jawab profesional seorang bidan dalam pemberian obat:

1. Memastikan kompetensi dalam pemberian obat.

Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh bidan agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan aman. Dalam hal pemberian obat, kompetensi ini sangat vital karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien.

2. Melakukan dokumentasi yang lengkap dan akurat mengenai obat yang diberikan.

Dokumentasi adalah bukti tertulis yang penting secara hukum maupun klinis mengenai layanan yang diberikan kepada pasien. Dalam pemberian obat, dokumentasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi pasien serta bidan secara hukum.

3. Memberikan edukasi dan konseling kepada pasien mengenai efek obat yang diberikan.

Edukasi dan konseling merupakan tanggung jawab inti dalam praktik kebidanan, khususnya saat memberikan obat. Melalui edukasi, pasien akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengobatan yang diterima, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terapi.

4. Menghormati hak pasien untuk menolak pengobatan.

Setiap pasien memiliki hak otonomi penuh atas dirinya, termasuk dalam hal menerima atau menolak suatu pengobatan. Bidan wajib menghormati keputusan tersebut setelah memberikan edukasi dan informasi lengkap kepada pasien.

C. Keamanan dan Efektivitas Obat

Dalam praktik kebidanan, aspek keamanan dan efektivitas obat merupakan dua komponen yang harus menjadi perhatian utama seorang bidan dalam memberikan pelayanan farmakologi. Keamanan (safety) mencakup jaminan bahwa penggunaan obat tidak akan menimbulkan bahaya yang signifikan bagi pasien, sedangkan efektivitas

(efficacy) merujuk pada kemampuan obat untuk memberikan efek terapeutik yang diharapkan. Kedua aspek ini harus selalu seimbang dan dipertimbangkan secara menyeluruh guna memastikan bahwa pasien menerima manfaat optimal dengan risiko yang minimal.

Pertama, terkait dengan pemantauan reaksi obat dan efek samping, bidan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamatan secara aktif terhadap pasien setelah pemberian obat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya respon negatif atau efek samping yang mungkin muncul dari terapi obat tersebut. Hal ini sangat penting karena tubuh setiap individu memiliki variasi yang berbeda dalam merespons obat, baik dari segi manfaat maupun kemungkinan efek negatifnya. Oleh karena itu, observasi berkala, baik melalui wawancara klinis maupun pemeriksaan fisik, wajib dilakukan secara kontinu untuk mendeteksi reaksi obat secara dini. Dengan pemantauan yang teliti dan teratur, risiko komplikasi yang serius dapat diminimalisir atau bahkan dicegah. Jika ditemukan adanya efek samping yang signifikan atau mengganggu pasien, bidan harus segera melakukan intervensi, misalnya dengan menghentikan penggunaan obat atau mengurangi dosis sesuai kondisi klinis pasien, dan jika diperlukan melakukan konsultasi dengan dokter atau spesialis yang terkait.

Kedua, terkait dengan penyesuaian dosis obat berdasarkan respons pasien serta kondisi klinis yang dialami, maka seorang bidan harus memahami bahwa pemberian obat tidak boleh bersifat statis atau tetap tanpa evaluasi lebih

lanjut. Kondisi klinis pasien dapat berubah dengan cepat, khususnya dalam masa-masa kritis seperti kehamilannya, persalinan, masa nifas, atau menyusui. Setiap pasien mungkin memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap obat tertentu, sehingga dosis obat yang optimal dapat berbeda-beda antar individu. Bidan harus secara rutin menilai apakah dosis obat yang diberikan telah memberikan hasil yang diinginkan dalam hal perbaikan kondisi klinis pasien, dan juga memastikan bahwa dosis tersebut tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan efek samping atau toksisitas, maupun tidak terlalu rendah yang mengurangi efektivitas pengobatan. Penyesuaian dosis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil observasi dan evaluasi klinis, seperti respons pasien terhadap terapi, munculnya gejala baru, perbaikan atau perburukan kondisi kesehatan pasien, serta indikator lain yang relevan dalam praktik kebidanan.

Ketiga, pemilihan obat yang tepat sangat penting dalam konteks praktik kebidanan karena populasi pasien yang dilayani memiliki kondisi khusus seperti kehamilan, proses persalinan, masa nifas, dan menyusui. Kondisi ini memerlukan perhatian ekstra dalam menentukan obat yang digunakan karena adanya kemungkinan dampak langsung kepada janin atau bayi yang sedang disusui. Bidan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kategori obat yang aman digunakan pada berbagai kondisi kebidanan ini. Sebagai contoh, dalam masa kehamilannya, pilihan obat harus memperhitungkan kategori risiko obat yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, sehingga risiko

teratogenik atau kelainan perkembangan janin dapat diminimalkan. Selama proses persalinan, pemilihan obat juga harus dipertimbangkan dengan seksama agar tidak mengganggu proses kelahiran alami atau membahayakan ibu dan bayi. Pada masa nifas, perhatian khusus ditujukan untuk memastikan obat yang diberikan tidak mempengaruhi proses pemulihan ibu atau menimbulkan komplikasi baru, dan pada masa menyusui, obat yang digunakan harus dipastikan aman serta tidak menimbulkan risiko yang signifikan bagi bayi yang disusui melalui ekskresi obat ke dalam Air Susu Ibu (ASI).

D. Terapi Komplementer dalam Asuhan Kebidanan

Dalam praktik kebidanan modern, terapi komplementer menjadi semakin populer sebagai pendekatan yang melengkapi pengobatan medis konvensional. Terapi komplementer mengacu pada berbagai metode nonfarmakologi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional pasien. Terapi ini sangat dihargai karena sifatnya yang alami, minim efek samping, serta mampu meningkatkan kenyamanan, relaksasi, dan kualitas hidup pasien, terutama dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui. Di bawah ini adalah penjelasan detail mengenai berbagai terapi komplementer yang sering digunakan dalam asuhan kebidanan:

1. Aromaterapi

Aromaterapi adalah penggunaan minyak esensial dari tanaman untuk tujuan terapeutik. Minyak esensial ini diekstrak dari bunga, daun, batang, atau akar tanaman tertentu, dan penggunaannya dapat dilakukan melalui inhalasi (hirupan), pijatan, atau mandi aromatik. Dalam kebidanan, aromaterapi secara umum digunakan untuk mengurangi kecemasan, meredakan nyeri persalinan, meningkatkan kualitas tidur, serta menciptakan suasana tenang bagi ibu hamil atau menyusui. Contoh minyak esensial yang sering digunakan adalah lavender untuk relaksasi dan pereda nyeri, peppermint untuk mengatasi mual dan muntah pada trimester awal kehamilan, serta citrus untuk meningkatkan suasana hati ibu.

Aromaterapi harus digunakan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kemungkinan reaksi alergi atau sensitivitas pasien terhadap minyak esensial tertentu. Oleh karena itu, konsultasi dengan profesional terlatih menjadi penting sebelum penggunaannya secara rutin dalam asuhan kebidanan.

2. Akupresur

Akupresur adalah teknik terapi tradisional yang berasal dari Tiongkok, yang didasarkan pada konsep titik-titik tertentu pada tubuh yang ditekan untuk mengalirkan energi dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Dalam konteks kebidanan, akupresur sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit selama persalinan, mengatasi mual pada masa kehamilan, serta membantu relaksasi secara umum.

Tekanan lembut namun terarah pada titik-titik akupresur tertentu dapat membantu merangsang pelepasan hormon endorfin yang memberikan efek analgesik alami, meningkatkan kenyamanan pasien, dan mengurangi ketegangan fisik maupun emosional. Praktik akupresur harus dilakukan oleh bidan atau terapis yang terlatih dengan baik untuk memastikan efektivitas dan keamanannya bagi pasien.

3. Teknik relaksasi dan meditasi

Teknik relaksasi dan meditasi adalah metode komplementer yang berfokus pada mengurangi stres dan ketegangan melalui latihan pernapasan, visualisasi, serta pengendalian pikiran. Teknik ini bertujuan menciptakan suasana mental dan emosional yang tenang, yang secara langsung berkontribusi pada kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil, bersalin, maupun dalam masa nifas.

Dalam praktik kebidanan, teknik-teknik ini dapat mengurangi kecemasan, membantu ibu mengelola nyeri persalinan secara efektif, serta meningkatkan kemampuan coping (daya tahan emosional) selama masa postpartum. Meditasi mindfulness, teknik visualisasi positif, dan latihan pernapasan dalam adalah beberapa metode yang sering digunakan untuk membantu ibu merasa lebih tenang, fokus, dan mampu mengendalikan stres secara efektif selama kehamilan hingga menyusui.

4. Terapi pijat

Terapi pijat adalah metode terapi yang menggunakan sentuhan atau manipulasi jaringan lunak

tubuh (kulit, otot, jaringan ikat) dengan tekanan ringan hingga sedang untuk menciptakan efek relaksasi, mengurangi ketegangan otot, memperbaiki sirkulasi darah, serta membantu pemulihan fisik dan psikologis.

Dalam asuhan kebidanan, terapi pijat banyak digunakan terutama pada masa kehamilan akhir dan proses persalinan, karena mampu mengurangi nyeri punggung, ketegangan otot, edema (pembengkakan), serta memberikan rasa nyaman secara keseluruhan. Selama masa nifas, terapi pijat dapat membantu mempercepat pemulihan fisik dan meningkatkan kesejahteraan emosional ibu baru. Penting untuk dipahami bahwa pijat kebidanan harus dilakukan dengan teknik khusus yang sesuai dengan kondisi spesifik ibu hamil atau postpartum, serta dilakukan oleh praktisi yang memiliki keahlian khusus dalam terapi pijat untuk kehamilan dan persalinan.

5. Penggunaan herbal dan suplemen nutrisi

Penggunaan herbal dan suplemen nutrisi sebagai terapi komplementer dalam kebidanan adalah pendekatan holistik yang menggunakan tanaman atau produk alami tertentu untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan. Herbal atau suplemen nutrisi tertentu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah defisiensi nutrisi, mempercepat pemulihan tubuh ibu setelah persalinan, serta mendukung produksi ASI yang optimal.

Beberapa herbal seperti daun raspberry, fenugreek, dan jahe sering digunakan dalam kebidanan untuk berbagai tujuan terapeutik, seperti mempersiapkan rahim untuk persalinan, meningkatkan produksi ASI, atau mengurangi mual selama kehamilan. Namun, penting sekali bagi bidan untuk memastikan keamanan penggunaan herbal ini, mengingat beberapa herbal dapat berinteraksi dengan obat-obatan medis atau memiliki kontraindikasi tertentu selama kehamilan dan menyusui. Karena itu, sebelum merekomendasikan penggunaan herbal atau suplemen nutrisi, bidan harus melakukan evaluasi mendalam mengenai kondisi pasien dan bukti ilmiah mengenai efektivitas serta keamanannya.

E. Integrasi Terapi Komplementer dan Konvensional

Integrasi terapi komplementer dengan pengobatan medis konvensional merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang semakin banyak digunakan dalam praktik kebidanan. Pendekatan ini bertujuan memaksimalkan hasil klinis, meningkatkan kesejahteraan pasien secara holistik, dan memberikan pilihan pengobatan yang lebih luas kepada pasien, dengan memanfaatkan keuntungan masing-masing metode terapi. Namun, integrasi ini bukanlah sekadar gabungan asal-asalan, melainkan harus dilakukan dengan kehati-hatian serta didasarkan pada prinsip ilmiah, medis, dan etika yang jelas. Dalam praktik kebidanan, terdapat beberapa faktor utama yang harus diperhatikan secara teliti

saat mengintegrasikan terapi komplementer dengan pengobatan medis konvensional.

Faktor pertama adalah kesesuaian terapi komplementer dengan kondisi medis pasien. Dalam menerapkan terapi komplementer, seorang bidan wajib melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh, termasuk riwayat medis, kehamilan saat ini, kondisi persalinan atau postpartum, serta status kesehatan bayi yang dikandung atau disusui. Tidak semua terapi komplementer cocok untuk setiap pasien, dan kondisi medis tertentu mungkin memiliki kontraindikasi atau interaksi yang signifikan dengan terapi komplementer tertentu. Misalnya, pasien dengan kondisi medis tertentu seperti hipertensi gestasional atau diabetes gestasional mungkin memerlukan pertimbangan khusus sebelum menggunakan terapi herbal tertentu, yang dapat berinteraksi atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi kesehatan pasien, risiko komplikasi dapat dihindari, sehingga terapi komplementer benar-benar memberikan manfaat tambahan tanpa menimbulkan risiko baru.

Faktor kedua yang penting adalah adanya penelitian atau bukti ilmiah pendukung yang kuat tentang terapi komplementer yang dipilih. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan kesehatan, semakin banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji efektivitas dan keamanan berbagai terapi komplementer dalam konteks kebidanan. Penting bagi seorang bidan untuk selalu merujuk pada bukti-bukti ilmiah

terbaru sebelum merekomendasikan atau menggunakan terapi komplementer tertentu. Terapi yang memiliki dasar bukti ilmiah yang kuat tentunya lebih dapat diandalkan, lebih efektif, dan lebih aman untuk pasien. Sebagai contoh, terapi seperti aromaterapi dan akupresur dalam mengurangi nyeri persalinan telah didukung oleh berbagai penelitian klinis yang menunjukkan hasil positif dan risiko minimal. Sebaliknya, terapi dengan bukti ilmiah yang lemah atau kurang jelas harus digunakan secara hati-hati atau dihindari sepenuhnya, guna mencegah risiko efek samping atau hasil yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penerapan terapi komplementer harus selalu berlandaskan evidence-based practice atau praktik berbasis bukti ilmiah.

Faktor ketiga, dan tidak kalah pentingnya, adalah komunikasi yang efektif antara pasien dan tenaga kesehatan tentang manfaat, risiko, serta batasan dari terapi komplementer yang digunakan. Proses komunikasi ini harus bersifat terbuka, jelas, dan dua arah, dimana pasien diberikan ruang yang cukup untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan kekhawatiran atau preferensi pribadi mereka tentang pengobatan yang akan dijalani. Komunikasi efektif memastikan pasien memiliki pemahaman yang realistis mengenai potensi manfaat terapi komplementer yang akan digunakan, serta memahami secara jelas risiko atau efek samping yang mungkin timbul dari terapi tersebut. Selain itu, batasan terapi komplementer juga harus dijelaskan dengan jelas, misalnya, terapi komplementer tidak menggantikan sepenuhnya pengobatan medis yang sudah terbukti efektif

secara ilmiah, tetapi merupakan pelengkap atau dukungan tambahan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien secara holistik. Hal ini penting agar pasien tidak memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau keliru terhadap terapi komplementer yang dipilih.

Komunikasi yang baik juga memastikan bahwa keputusan mengenai integrasi terapi komplementer adalah keputusan bersama antara pasien dan bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Hal ini sangat penting dalam menjaga hak otonomi pasien, serta memperkuat hubungan kepercayaan terapeutik antara pasien dengan tenaga kesehatan yang merawatnya. Tenaga kesehatan juga harus selalu terbuka dan objektif dalam memberikan saran, tidak memaksakan suatu terapi tertentu, tetapi memberikan penjelasan yang seimbang berdasarkan bukti ilmiah serta kondisi klinis pasien. Jika terdapat keraguan atau kekhawatiran tertentu mengenai terapi komplementer, maka bidan harus secara proaktif melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten dalam bidang terapi komplementer tertentu, untuk memastikan integrasi yang aman dan optimal dalam pelayanan kesehatan yang diberikan.

F. Latihan soal

Soal 1: Etika dalam Pemberian Obat (Otonomi Pasien)

Seorang ibu hamil berusia 28 tahun datang ke klinik kebidanan. Bidan berencana memberikan suplementasi zat besi karena ditemukan tanda-tanda anemia ringan. Sebelum

memberikan obat, tindakan paling tepat yang dilakukan bidan adalah:

- A. Memberikan obat tanpa penjelasan agar pasien tidak khawatir.
- B. Menjelaskan tujuan, dosis, efek samping, serta alternatif terapi kepada pasien.
- C. Memberikan obat terlebih dahulu dan menjelaskan setelah pasien bertanya.
- D. Memberikan penjelasan singkat tanpa menyebut efek sampingnya.
- E. Mengarahkan pasien untuk mencari informasi sendiri tentang obat tersebut.

Kunci Jawaban: Menjelaskan tujuan, dosis, efek samping, serta alternatif terapi kepada pasien.

Rasional:

Jawaban yang tepat adalah B, karena bidan harus menghormati prinsip otonomi pasien dengan memberikan informasi lengkap terkait indikasi, dosis, efek samping, dan alternatif terapi sehingga pasien dapat memberikan persetujuan secara informatif.

Soal 2: Beneficence dalam Pemberian Obat

Seorang ibu postpartum mengalami nyeri hebat pada luka jahitan perineumnya. Bidan memutuskan memberikan analgesik yang aman untuk ibu menyusui. Prinsip etika apakah yang diterapkan bidan dalam situasi ini?

- A. Justice (Keadilan)
- B. Non-maleficence (Tidak Merugikan)

- C. Beneficence (Berbuat Baik)
- D. Otonomi Pasien
- E. Informed consent

Kunci Jawaban: Beneficence (Berbuat Baik) (Kunci Jawaban)

Rasional:

Jawaban yang tepat adalah C. Prinsip Beneficence berarti bertindak demi memberikan manfaat maksimal, dalam kasus ini mengurangi nyeri untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan ibu postpartum.

Soal 3: Non-maleficence dalam Pemberian Obat

Seorang ibu hamil 34 minggu datang dengan keluhan sakit kepala ringan dan flu ringan. Ia meminta obat untuk mengatasi keluhannya. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh bidan adalah:

- A. Memberikan obat flu dengan dosis umum tanpa evaluasi lanjutan.
- B. Menjelaskan efek samping dan memastikan obat aman serta risiko minimal sebelum pemberian.
- C. Langsung meresepkan obat kuat agar keluhan cepat hilang.
- D. Meminta pasien untuk menahan keluhannya tanpa penjelasan.
- E. Menyarankan pasien langsung ke apotek untuk memilih obat sendiri.

Kunci Jawaban: B. Menjelaskan efek samping dan memastikan obat aman serta risiko minimal sebelum pemberian. (Kunci Jawaban)

Rasional:

Jawaban yang benar adalah B. Prinsip Non-maleficence mengharuskan bidan untuk memastikan bahwa manfaat terapi jauh melebihi risiko efek sampingnya, dengan evaluasi mendalam sebelum memberikan obat.

Soal 4: Integrasi Terapi Komplementer dalam Kebidanan

Seorang ibu hamil trimester ketiga datang dengan keluhan nyeri punggung ringan, bidan menawarkan terapi pijat sebagai pelengkap pengobatan medis konvensional yang sudah ia terima. Hal yang paling penting dilakukan bidan sebelum menerapkan terapi ini adalah:

- A. Melakukan terapi pijat langsung karena sudah terbukti aman pada semua ibu hamil.
- B. Memberikan pijatan yang keras agar nyeri cepat hilang tanpa komunikasi dengan pasien.
- C. Menjelaskan manfaat, risiko, batasan terapi pijat, serta mendapatkan persetujuan pasien.
- D. Mengabaikan terapi konvensional dan langsung menggunakan terapi pijat saja.
- E. Meminta pasien membaca informasi sendiri tentang terapi pijat di internet.

Kunci Jawaban: C. Menjelaskan manfaat, risiko, batasan terapi pijat, serta mendapatkan persetujuan pasien.

Rasional:

Jawaban tepat adalah C. Integrasi terapi komplementer mensyaratkan komunikasi yang jelas mengenai manfaat, risiko, dan batasan terapi sehingga pasien dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap.

Soal 5: Penggunaan Herbal dan Suplemen Nutrisi dalam Kebidanan

Seorang ibu menyusui datang dengan keluhan produksi ASI yang sedikit. Ia bertanya tentang penggunaan herbal fenugreek yang ia baca bisa meningkatkan produksi ASI. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan bidan adalah:

- A. Segera menyuruh ibu menggunakan herbal tanpa penjelasan lebih lanjut.
- B. Memberikan herbal tanpa pertimbangan medis karena ini terapi alami.
- C. Menjelaskan bukti ilmiah, manfaat, risiko penggunaan fenugreek, serta mempertimbangkan kondisi medis pasien sebelum merekomendasikan.
- D. Melarang ibu menggunakan herbal karena berisiko tinggi tanpa penjelasan tambahan.
- E. Menyarankan pasien untuk bertanya ke teman yang sudah menggunakan fenugreek sebelumnya.

Kunci Jawaban: C. Menjelaskan bukti ilmiah, manfaat, risiko penggunaan fenugreek, serta mempertimbangkan kondisi medis pasien sebelum merekomendasikan.

Rasional:

Jawaban yang tepat adalah C. Bidan harus menggunakan prinsip evidence-based practice, menjelaskan manfaat dan risiko, serta memastikan keamanan terapi herbal bagi kondisi medis pasien sebelum merekomendasikannya.

G. Rangkuman Materi

Dalam praktik kebidanan, pemberian obat dan terapi komplementer merupakan bagian integral yang harus dikelola secara profesional, etis, aman, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah. Bidan, sebagai tenaga kesehatan profesional, memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan pasien. Dalam aspek etika pemberian obat, bidan wajib menghormati otonomi pasien melalui pemberian informasi yang lengkap, jelas, serta memastikan pasien memberikan persetujuan tanpa tekanan. Prinsip beneficence menuntut bidan untuk selalu bertindak demi kebaikan pasien, memilih terapi yang tepat, memantau efektivitasnya, serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan (non-maleficence). Prinsip keadilan juga menegaskan bahwa bidan harus memberikan pengobatan secara adil dan tanpa diskriminasi, mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi pasien agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara dalam menerima pengobatan.

Tanggung jawab profesional bidan mencakup kompetensi dalam memberikan obat secara tepat dan aman, dokumentasi yang lengkap dan akurat sebagai bukti klinis maupun hukum, serta pemberian edukasi dan konseling agar

pasien memahami pengobatan dengan baik. Selain itu, bidan harus selalu menghormati hak pasien untuk menerima atau menolak pengobatan, dengan memastikan pasien memiliki informasi yang memadai untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam hal keamanan dan efektivitas obat, bidan wajib melakukan pemantauan aktif terhadap reaksi obat dan efek sampingnya, menyesuaikan dosis secara dinamis berdasarkan respons klinis pasien, serta memilih obat yang tepat sesuai kondisi khusus pasien seperti kehamilan, persalinan, nifas, maupun menyusui. Pemilihan obat harus didasarkan pada bukti ilmiah terkini, mempertimbangkan risiko minimal bagi ibu dan janin atau bayi yang disusui.

Sementara itu, terapi komplementer semakin populer dalam kebidanan sebagai pendekatan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional pasien secara holistik. Beberapa terapi yang umum digunakan antara lain aromaterapi, akupresur, teknik relaksasi dan meditasi, terapi pijat, serta penggunaan herbal dan suplemen nutrisi. Penting bagi bidan untuk memastikan keamanan terapi ini, mengingat beberapa terapi komplementer dapat memiliki interaksi atau kontraindikasi tertentu dengan kondisi medis pasien.

Integrasi terapi komplementer dengan terapi konvensional harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan kondisi medis pasien, didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, serta dilaksanakan melalui komunikasi yang terbuka dan efektif antara pasien dengan tenaga kesehatan.

Komunikasi yang baik akan memastikan pasien memiliki pemahaman realistis tentang manfaat, risiko, serta batasan terapi komplementer, sehingga keputusan tentang integrasi terapi menjadi keputusan bersama yang meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kebidanan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip etika, tanggung jawab profesional, keamanan, efektivitas obat, serta integrasi terapi komplementer dan konvensional dalam kebidanan akan menciptakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, aman, efektif, dan holistik bagi pasien.

H. Glosarium

Akupresur:

Teknik terapi tradisional asal Tiongkok yang menggunakan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi dan mengembalikan keseimbangan tubuh, sering digunakan dalam kebidanan untuk mengurangi nyeri persalinan dan mual pada masa kehamilan.

Alternatif Terapi:

Pilihan terapi atau pengobatan lain yang tersedia selain terapi utama yang ditawarkan kepada pasien, lengkap dengan informasi mengenai keuntungan dan risikonya.

Aromaterapi:

Penggunaan minyak esensial dari tanaman melalui inhalasi, pijatan, atau mandi aromatik untuk tujuan terapi seperti relaksasi, mengurangi kecemasan, nyeri persalinan, dan meningkatkan kualitas tidur ibu.

Beneficence (Berbuat Baik):

Prinsip etika yang mengharuskan tenaga kesehatan, termasuk bidan, untuk bertindak demi kebaikan pasien dengan memberikan pengobatan yang efektif dan aman untuk meningkatkan kesejahteraan pasien secara maksimal.

Dokumentasi Obat:

Catatan tertulis lengkap yang mencakup detail tentang obat yang diberikan kepada pasien, dosis, cara penggunaan, frekuensi, serta reaksi pasien terhadap obat tersebut, yang menjadi bukti klinis dan hukum dalam praktik kebidanan.

Efek Samping:

Reaksi negatif atau tidak diinginkan yang mungkin muncul dari penggunaan suatu obat atau terapi, yang wajib diinformasikan kepada pasien sebelum pemberian pengobatan.

Efektivitas Obat (Efficacy):

Kemampuan suatu obat atau terapi untuk mencapai hasil terapeutik yang diharapkan dalam pengobatan suatu kondisi kesehatan pasien.

Evidence-based Medicine:

Pendekatan pengobatan yang mengacu pada bukti ilmiah terbaru untuk memastikan terapi yang diberikan aman, efektif, serta berbasis penelitian dan fakta klinis.

Fenugreek:

Herbal yang umum digunakan dalam kebidanan, terutama untuk meningkatkan produksi Air Susu Ibu (ASI), yang penggunaannya harus didasarkan pada bukti ilmiah dan mempertimbangkan kondisi medis pasien.

Integrasi Terapi:

Penggabungan terapi komplementer dengan terapi medis konvensional secara hati-hati berdasarkan evaluasi klinis, bukti ilmiah, dan komunikasi efektif antara pasien dan tenaga kesehatan.

Justice (Keadilan):

Prinsip etika yang memastikan bahwa semua pasien diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi dalam pemberian obat maupun layanan kesehatan, berdasarkan kebutuhan klinis mereka.

Kompetensi Profesional:

Kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh bidan untuk memberikan pengobatan secara efektif, aman, dan bertanggung jawab dalam praktik kebidanan.

Meditasi Mindfulness:

Teknik meditasi yang berfokus pada perhatian penuh dan kesadaran terhadap kondisi saat ini, digunakan untuk mengurangi stres, kecemasan, serta membantu ibu hamil dan nifas dalam mengelola emosi dan nyeri secara efektif.

Non-maleficence (Tidak Merugikan):

Prinsip etika yang menegaskan kewajiban bidan untuk tidak melakukan tindakan yang berisiko merugikan atau menyebabkan bahaya yang lebih besar daripada manfaat terapi yang diberikan kepada pasien.

Otonomi Pasien:

Prinsip yang menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan mandiri tentang kesehatannya setelah

mendapatkan informasi lengkap mengenai terapi yang ditawarkan.

Pemantauan Reaksi Obat:

Observasi rutin dan aktif terhadap pasien setelah pemberian obat untuk mendeteksi secara dini efek samping atau reaksi negatif, sehingga dapat dilakukan tindakan segera jika diperlukan.

Persetujuan Tindakan (Informed Consent):

Proses pemberian informasi yang jelas kepada pasien tentang suatu terapi atau pengobatan sehingga pasien dapat secara sukarela memberikan persetujuan tanpa paksaan.

I. Daftar Pustaka

Aurellia, D. (2023). Pelayanan kebidanan komplementer. STIKES BCM.

Basil, V. (2021). Principles of clinical ethics and their application to practice. *The Permanente Journal*, 25, 1–8. <https://doi.org/10.7812/TPP/20.072>

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Alma Ata. (2019, July 20). Prinsip etik dalam keperawatan. <https://fikes.almaata.ac.id/prinsip-etik-dalam-keperawatan/>

Khuzaiyah, S. (2025). Konsep dasar dan urgensi pelayanan kebidanan komplementer. Dalam *Terapi komplementer kebidanan* (hlm. 1–16). Media Sains Indonesia.

Ministry of Health of the Republic of Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Saptabakti, S. (n.d.). Buku ajar etika dalam praktik kebidanan. STIKES Sapta Bakti.
<https://repository.stikessaptabakti.ac.id/375/1/13.%20Modul%20Ajar%20-%20Etika%20dalam%20praktik%20kebidanan.pdf>

Setyaningsih, R., & Rufaida, A. (2021). Modul kebidanan komplementer. STIKES Binawan.
<https://repository.binawan.ac.id/3452/1/Modul%20Kebidanan%20Komplementer.pdf>

Varkey, B. (2021). Principles of clinical ethics and their application to practice. The Permanente Journal, 25, 1–8. <https://doi.org/10.7812/TPP/20.072>

Yulianti, D. (2024). Terapi komplementer dalam pelayanan kebidanan. STIKES Deli Husada.
<https://fkeb.delihusada.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/21.-Buku-Terapi-Komplementer-Dalam-Pelayanan-Kebidanan-.pdf>

PROFIL PENULIS



Suci Gustia Saputri, S.Tr.Keb., MPH

Lahir di Ketapang, 09 Agustus 1997
Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang d4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022-2023 saya mulai bekerja menjadi Asisten Peneliti di Pusat Kajian Kesehatan Anak / Center For Child Health FKMK UGM. Saat ini penulis bekerja di Stikes Prima Indonesia mengampu mata kuliah Epidemiologi dan Statistik, kebidanan komplementer, dan Praktik Dasar Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sucigustiasaputri@gmail.com

PROFIL PENULIS



Gita Kostania, S.ST., M.Kes., lahir di Cilacap, 16 Desember 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis meliputi jenjang Diploma III pada Program Studi Diploma III Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan Diploma IV pada Program Studi D4 Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister pada peminatan

Pendidikan Profesi Kesehatan, Program Studi Magister Kedokteran di universitas yang sama, dan lulus pada tahun 2011.

Riwayat pekerjaan penulis dimulai sebagai dosen tetap pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Surakarta sejak tahun 2012 hingga 2020, kemudian melanjutkan tugas sebagai dosen pada Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Malang sejak tahun 2020 hingga saat ini. Saat ini, penulis aktif mengampu beberapa mata kuliah pada Program Studi Diploma III dan Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Malang, salah satunya adalah mata kuliah Farmakologi Kebidanan.

Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis juga aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis telah mempublikasikan berbagai karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel jurnal, serta memiliki beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Informasi selengkapnya dapat dilihat melalui profil SINTA penulis di: <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5982765>.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gita.kostania@poltekkes-malang.ac.id.

PROFIL PENULIS



Tonasih, SST.,M.Kes.

Lahir di Brebes, 22 Oktober 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Prodi Kebidanan Cirebon lulus tahun 2003, DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Bandung lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro Semarang, Lulus tahun 2013. Saat ini sedang Studi Lanjut di S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003-2004 sebagai Bidan Pelaksana di BPM Sejahtera di Cirebon, tahun 2004-2005 sebagai Bidan Pelaksana di Klinik Nastiti Jakarta Selatan, tahun 2005-2006 sebagai Bidan Pelaksana di Klinik Cijerah Bandung, tahun 2006-2009 sebagai Tenaga Pendidik di Prodi D3 Kebidanan STIKes Indramayu. Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Penulis mengabdikan diri sebagai Dosen di Akbid Muhammadiyah Cirebon yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon. Selain sebagai Dosen, Penulis juga menjadi Bidan Pelaksana dengan membuka Tempat Praktik Bidan Mandiri (TPMB) mulai tahun 2013 sampai 2019.

Saat ini penulis menjadi Dosen di Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UMMADA Cirebon dengan mengampu beberapa mata kuliah, antara lain: Asuhan Kebidanan Nifas, Sosioantropologi Kesehatan, Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan, Holistik Care dan Spiritual Islam, Manajemen Pelayanan Kebidanan.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penulis Buku, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar, Publikasi Artikel pada Jurnal Nasional baik Tidak Terakreditasi maupun Terakreditasi. Penulis juga telah memiliki beberapa karya yang sudah di hak cipta kan baik buku maupun karya yang lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asih_islamiyah@yahoo.co.id

Motto: "Hidup adalah Perjuangan"

Sinopsis

Buku Ajar "Farmakologi dalam Asuhan Kebidanan" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip farmakologi yang esensial dalam praktik kebidanan. Dimulai dari penjelasan mengenai konsep dasar farmakologi, farmakodinamika, dan farmakokinetika, buku ini menyajikan pembahasan yang jelas dan mendalam, membantu pembaca memahami bagaimana obat bekerja, serta proses yang dilalui obat di dalam tubuh manusia. Materi disusun secara sistematis dilengkapi latihan soal, rangkuman materi, dan glosarium untuk memperkuat pemahaman pembaca.

Selanjutnya, buku ini membahas secara rinci tentang prinsip pemberian obat, mulai dari metode pemberian yang tepat hingga cara mengatasi efek samping atau adverse drug reactions (ADRs). Bab ini disusun secara praktis dengan berbagai latihan soal yang relevan, disertai rangkuman dan glosarium, yang memungkinkan pembaca memahami secara mendalam berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik pemberian obat, sekaligus cara-cara efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Bagian akhir buku ini mengulas secara khusus aspek etika dalam pemberian obat, yang menekankan tanggung jawab profesional seorang bidan dalam menjaga keamanan dan efektivitas obat yang diberikan kepada pasien. Selain itu, integrasi terapi komplementer dengan pengobatan konvensional turut dibahas sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan. Buku ini merupakan referensi penting yang mendukung pengembangan kompetensi profesional bagi mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam memberikan asuhan yang aman, etis, dan efektif.

Buku Ajar "Farmakologi dalam Asuhan Kebidanan" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip farmakologi yang esensial dalam praktik kebidanan. Dimulai dari penjelasan mengenai konsep dasar farmakologi, farmakodinamika, dan farmakokinetika, buku ini menyajikan pembahasan yang jelas dan mendalam, membantu pembaca memahami bagaimana obat bekerja, serta proses yang dilalui obat di dalam tubuh manusia. Materi disusun secara sistematis dilengkapi latihan soal, rangkuman materi, dan glosarium untuk memperkuat pemahaman pembaca. Selanjutnya, buku ini membahas secara rinci tentang prinsip pemberian obat, mulai dari metode pemberian yang tepat hingga cara mengatasi efek samping atau adverse drug reactions (ADRs). Bab ini disusun secara praktis dengan berbagai latihan soal yang relevan, disertai rangkuman dan glosarium, yang memungkinkan pembaca memahami secara mendalam berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik pemberian obat, sekaligus cara-cara efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Bagian akhir buku ini mengulas secara khusus aspek etika dalam pemberian obat, yang menekankan tanggung jawab profesional seorang bidan dalam menjaga keamanan dan efektivitas obat yang diberikan kepada pasien. Selain itu, integrasi terapi komplementer dengan pengobatan konvensional turut dibahas sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan. Buku ini merupakan referensi penting yang mendukung pengembangan kompetensi profesional bagi mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam memberikan asuhan yang aman, etis, dan efektif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-12-8



9

786347

294128